AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

HEMATOLOGÍA

Oncología Médica

24 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Síndromes Anémicos Hipoproliferativos y Carenciales

★☆☆ 8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario 4
★★☆ 8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina 5
★★★ 8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa GES 6
★☆☆ 8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) GES 8
★☆☆ 8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos 9

02 Anemias Macrocíticas, Hemolíticas y Hemoglobinopatías

★★★ 8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato 10
★★☆ 8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo 11
★★☆ 8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 13
★☆☆ 8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) 14
★★★ 8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU 15

03 Hemostasia Primaria, Plaquetas y Coagulopatías

★☆☆ 8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno 16
★★★ 8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES 17
★★★ 8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand GES 19
★★☆ 8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes 21
★☆☆ 8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo 22

04 Oncohematología: Neoplasias Mieloides y Linfoides

★★★ 8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante GES 23
★★☆ 8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) GES 24
★★★ 8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) GES 25
★★☆ 8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) GES 26
★☆☆ 8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia 27

05 Urgencias Oncohematológicas, Trombofilias y Medicina Transfusional

★★☆ 8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica GES 28
★★★ 8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular 29
★★☆ 8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo 30
★☆☆ 8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas 31

Índice · continuación

Números que tienes que saber	32
Fármacos de primera línea	35
GES de la especialidad	36
Plan de repaso de 7 días	38
Índice por prioridad ★	39

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.1 Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

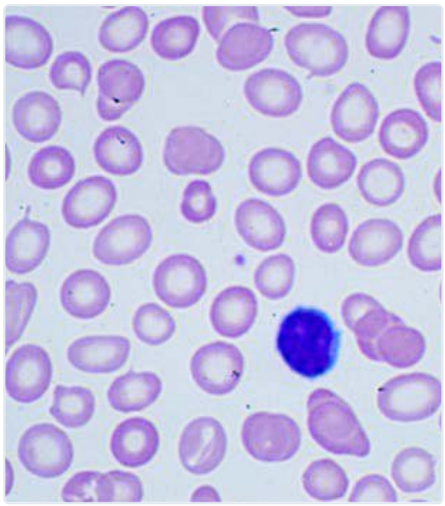
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

Alta · Criterios diagnósticos OMS (Hb <13 g/dL en hombres, <12 g/dL en mujeres) y clasificación fisiopatológica

1.08.4.008 **Hemograma** — Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Puntos de corte OMS**: Hb < **13 g/dL** en varones y < **12 g/dL** en mujeres adultas no embarazadas.
- El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ **3 ×** Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- **IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa**: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- **IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa**: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.
- Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.
- Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.



RETICULOCITOS TEÑIDOS
Harrison, Principios de Medicina Interna, Fig. 62-2

ALGORITMO · ENFRENTAMIENTO INICIAL DE LA ANEMIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

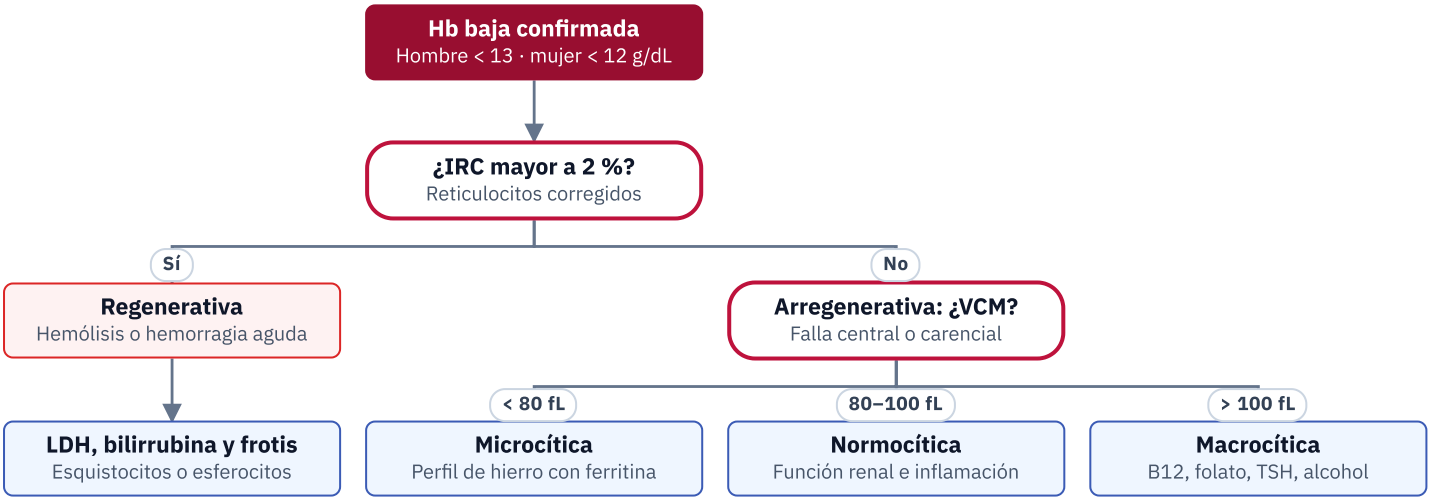


TABLA 8.1 · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ANEMIAS SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO

CATEGORÍA VCM	RETICULOCITOS (IRC)	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	FROTIS Y MARCADORES CLAVE
Microcítica (< 80 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Anemia Ferropénica, Rasgo Talasémico, Anemia Sideroblástica	Hipocromía, microcitosis, poiquilocitosis, RDW aumentado en ferropenia
Normocítica (80-100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Enfermedad Crónica/Inflamatoria, ERC, Mieloma Múltiple, Aplasia	Rouleaux en mieloma; normocromía; ferritina elevada en inflamación
Normocítica (80-100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Anemia Hemolítica Aguda, Hemorragia Aguda reciente	Esquistocitos (PTT/SHU), esferocitos (AHAI), policromatofilia intensa
Macrocítica (> 100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Déficit Vitamina B12, Déficit Folato, Consumo Etílico, Hipotiroidismo	Neutrófilos hipersegmentados (pleocariocitos), macroovalocitos
Macrocítica (> 100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Crisis hemolítica intensa con reticulocitosis extrema masiva	Los reticulocitos son más voluminosos (>110 fL) y elevan el VCM medido

REGLA DE ORO **Hb < 13 hombre, < 12 mujer** — Embarazo: < 11; manda la Hb, no el Hto

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **1–7** (págs. 6–7) · solucionario págs. 18–19.

Clase 8.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.002 Anemia ferropénica — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Anemia de las enfermedades crónicas

LO QUE TE PREGUNTAN

- La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.
- **La ferritina es un reactante de fase aguda positivo**: en presencia de PCR elevada, valores < 100 ng/mL aún sugieren ferropenia.
- La transferrina plasmática es un reactante de fase aguda negativo: desciende en sepsis, artritis, cáncer y uremia.
- En la anemia ferropénica pura la transferrina y la TIBC se encuentran elevadas.
- La ferremia aislada carece de valor diagnóstico diferencial debido a sus fluctuaciones y caída tanto en ferropenia como en infección.

ALGORITMO · LECTURA DEL PERFIL DE HIERRO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

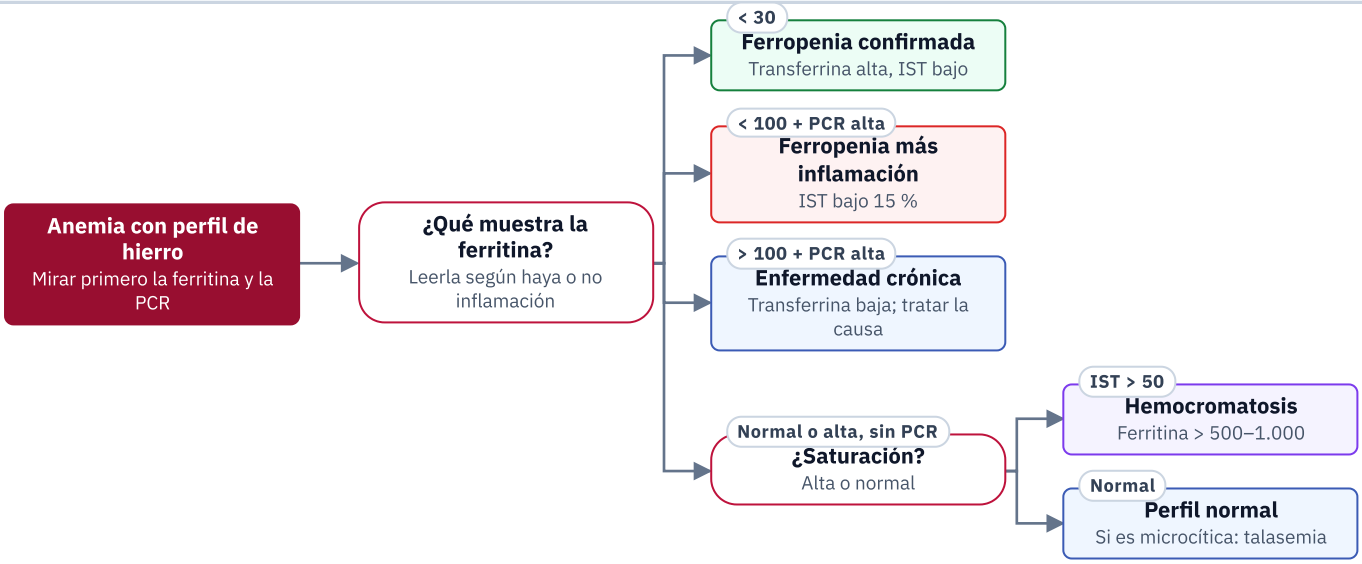


TABLA 8.2 · PATRONES DIAGNÓSTICOS DEL PERFIL MARCIAL EN PATOLOGÍAS FRECUENTES

PARÁMETRO	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA	RASGO TALASÉMICO MENOR
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100-300 ng/mL)	Muy Elevada (> 500-1.000 ng/mL)	Normal o Ligeramente Elevada
Transferrina / TIBC	Aumentada (Síntesis ↑)	Disminuida (Reactante negativo)	Disminuida o Normal	Normal
Hierro Sérico (Ferremia)	Muy Disminuido	Disminuido (Hierro secuestrado)	Muy Aumentado	Normal
Saturación Transferrina (IST)	Muy Baja (< 15%)	Baja o Normal (15-25%)	Muy Alta (> 50-60%)	Normal (25-40%)
Mecanismo Central	Agotamiento de depósitos	Secuestro marcial por hepcidina	Mutación gen HFE (sobreabsorción)	Mutación cadenas globina (no falta hierro)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	FERRITINA	TRANSFERRINA Y TIBC	SATURACIÓN (IST)
Anemia ferropénica	Baja (< 30 ng/mL)	Aumentada	Muy baja (< 15 %)
Rasgo talasémico menor	Normal o levemente alta	Normal	Normal (25–40 %)
Ferropenia con inflamación	< 100 ng/mL con PCR alta	—	< 15 %

REGLA DE ORO **Ferritina < 30: ferropenia** — Con inflamación, < 100 aún es ferropenia

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **8–12** (pág. 7) · solucionario págs. 19–20.

Clase 8.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

Máxima · Primera causa de anemia en el mundo y en Chile; estudio de hemorragia oculta y esquema de sulfato ferroso

1.08.1.002 **Anemia ferropénica** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Anemia ferropriva

LO QUE TE PREGUNTAN

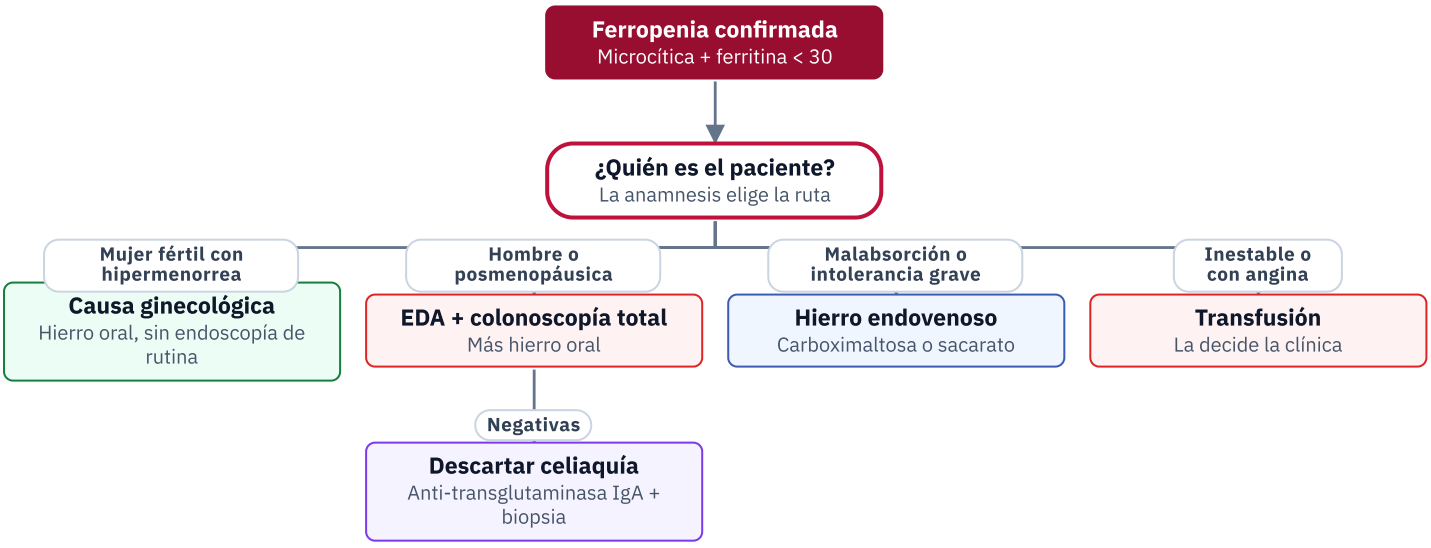
- La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.
- En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica dirigida suele ser suficiente.
- La ferritina sérica < 30 ng/mL confirma el diagnóstico de ferropenia con máxima sensibilidad y especificidad.
- La dosis moderna de hierro oral es de **40 a 100 mg** de Fe elemental/día o en días alternos para no saturar la hepcidina.
- El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas alarmas de melena.
- La respuesta medular se objetiva al 5°-7° día con el pico de reticulocitos; la Hb se normaliza al 1°-2° mes.
- El hierro oral debe mantenerse durante **3 a 6 meses** tras normalizar la Hb para repletar depósitos de ferritina.



COILONIQUIA
Wikimedia Commons «Koilonychia iron deficiency anemia.jpg», CC BY 2.0, CHeitz

ALGORITMO · ANEMIA FERROPÉNICA: ESTUDIO Y TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **13–14** (págs. 7–8) · solucionario pág. 21.

Clase 8.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.3 · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA: HIERRO ORAL VS HIERRO ENDOVENOSO EN APS Y HOSPITAL

PARÁMETRO	HIERRO ORAL (SULFATO FERROSO)	HIERRO ENDOVENOSO (CARBOXIMALTOSA / SACARATO)
Indicación Principal	Tratamiento estándar de 1ª línea en ferropenia ambulatoria no complicada	Malabsorción intestinal, EII, bypass gástrico, intolerancia oral grave, ERC en diálisis, 3er trimestre embarazo
Vía y Posología	Oral: 200 mg sulfato ferroso (40-60 mg Fe elemental) 1 vez/día o días alternos	Infusión EV: 500 a 1.000 mg en dilución salina en 15-30 minutos en ambiente monitorizado
Ventajas	Bajo costo, disponibilidad universal en red pública GES/APS, fácil administración	Repleción marcial ultrarrápida, 100% biodisponible, no depende del transporte duodenal
Efectos Adversos	Dispepsia, náuseas, constipación, diarrea, tinción oscura de heces	Cefalea, rubor facial, flebitis local, náuseas transitorias, hipofosfemia leve transitoria
Duración Terapia	Normalización de Hb en 1-2 meses + 3 a 6 meses extra para llenar depósitos	Dosis total calculada por fórmula de Ganzoni administrada en 1 a 2 sesiones

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hombre o posmenopáusica con ferropenia	EDA + colonoscopía total + hierro oral	Solo recetar hierro
Mujer fértil con hipermenorrea, sin síntomas digestivos	Hierro oral y manejo ginecológico	Endoscopía de rutina inmediata
Endoscopías negativas y falla del hierro oral	Anti-transglutaminasa IgA + biopsia duodenal	Subir la dosis de hierro oral

REGLA DE ORO **La ferropenia es un síntoma** — Sangrado o malabsorción

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en la práctica médica global y en el examen EUNACOM. El error más grave evaluado en el examen es limitar el manejo a recetar suplementos de hierro sin investigar exhaustivamente la causa de la pérdida. En hombres de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la anemia ferropénica debe considerarse secundaria a una neoplasia digestiva oculta (cáncer de colon derecho o gástrico) hasta demostrar lo contrario mediante estudio endoscópico completo.

TABLA 8.3.B · CRONOGRAMA DE RESPUESTA TERAPÉUTICA AL HIERRO Y METAS CLÍNICAS

TIEMPO POSINICIO	PARÁMETRO CLAVE EVALUADO	COMPORTAMIENTO ESPERADO	CONDUCTA MÉDICA
48 a 72 horas	Estado General y Astenia	Mejoría subjetiva precoz por repleción de enzimas tisulares	Reasegurar al paciente y confirmar tolerancia digestiva
5 a 7 días	Recuento de Reticulocitos	Crisis reticulocitaria con pico máximo de reticulocitos	Primer marcador objetivo de respuesta biológica al tratamiento
3 a 4 semanas	Concentración de Hemoglobina	Aumento de Hb en al menos 1.5 a 2.0 g/dL respecto al basal	Si no sube: verificar adherencia, pérdidas persistentes o malabsorción
2 meses	Normalización Hemograma	Normalización de Hb y VCM a rangos de referencia	¡NO SUSPENDER EL HIERRO! Continuar tratamiento de mantención
3 a 6 meses	Ferritina Sérica	Ferritina sérica > 50-100 ng/mL (depósitos repletados)	Momento formal de suspensión del hierro oral y alta hematológica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **13–14** (págs. 7–8) · solucionario pág. 21.

Clase 8.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.1.001 Anemia de las enfermedades crónicas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Anemia en nefrópata

LO QUE TE PREGUNTAN

- La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.
- **Perfil clásico de la anemia de la inflamación**: ferritina elevada (> 100-300), transferrina baja y ferremia baja.
- La anemia en la ERC se debe primariamente al déficit de síntesis peritubular de eritropoyetina.
- Antes de iniciar eritropoyetina en un paciente renal es obligatorio repletar el hierro (ferritina > 200 ng/mL e IST > **20%**).
- La diana terapéutica de hemoglobina en la ERC con EPO es estrictamente de **10.0 a 11.5 g/dL**.
- Buscar normalizar la hemoglobina a > **12-13 g/dL** en ERC con EPO aumenta el riesgo de ACV, trombosis de fístula y muerte.

ALGORITMO · ANEMIA NORMOCÍTICA ARREGENERATIVA: INFLAMACIÓN O RIÑÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

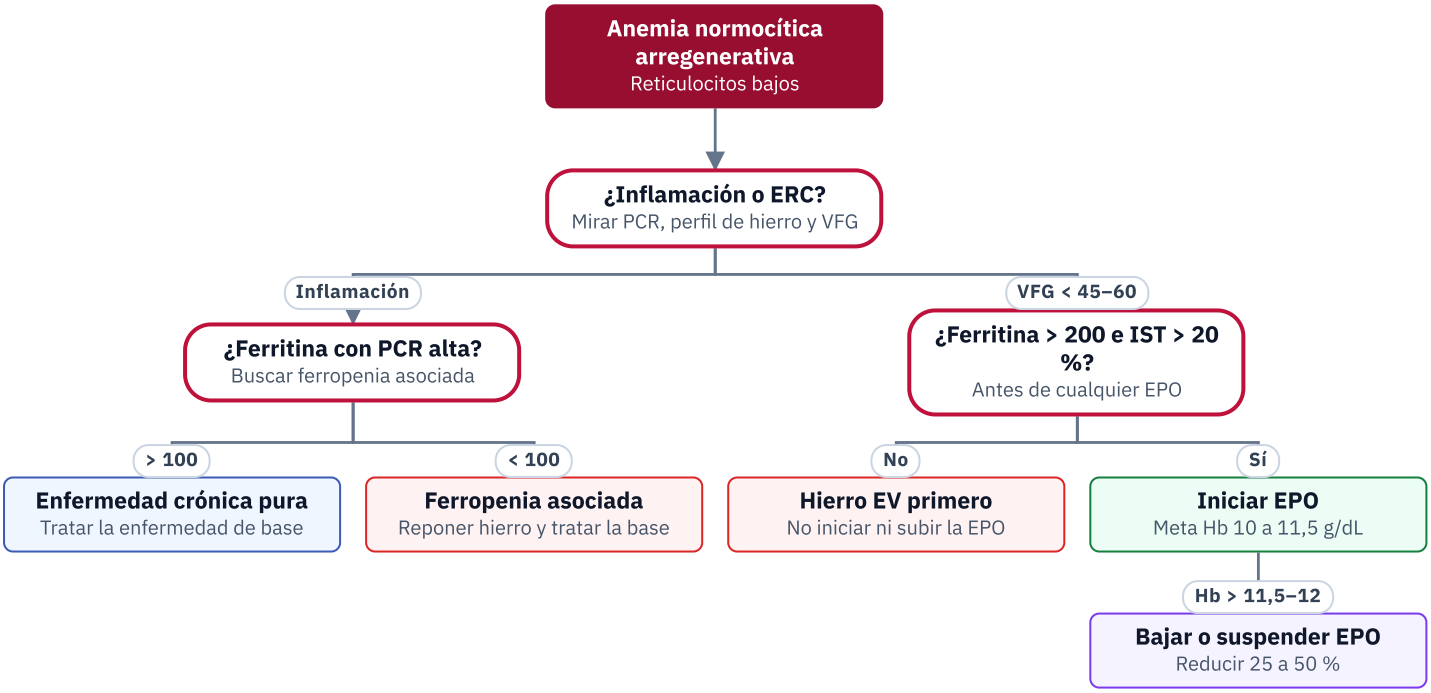


TABLA 8.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS ENFERMEDAD CRÓNICA VS ERC

CARACTERÍSTICA	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENF. CRÓNICAS	ANEMIA RENAL (ERC)
VCM Eritrocitario	Microcítica franca (< 80, fqte < 72 fL)	Normocítica (80-95); microcítica tardía	Normocítica normocrómica pura (80-100 fL)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100 a 500 ng/mL)	Normal o elevada (según estado inflamatorio)
Transferrina / TIBC	Aumentada (> 360 mg/dL)	Disminuida (< 200 mg/dL)	Normal o disminuida
Saturación Transferrina (IST)	Muy baja (< 15%)	Normal o baja (15-25%)	Normal o baja (evaluar ferropenia funcional)
Mecanismo Central	Falta total de hierro corporal	Secuestro marcial inducido por Hepcidina	Déficit de producción renal de Eritropoyetina
Tratamiento Fundamental	Hierro oral o endovenoso	Tratar la enfermedad inflamatoria de base	Hierro EV (repleción previa) + Eritropoyetina (AEE)

REGLA DE ORO **IL-6 → hepcidina → sin ferroportina** — El hierro queda atrapado

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **15–16** (pág. 8) · solucionario pág. 22.

Clase 8.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

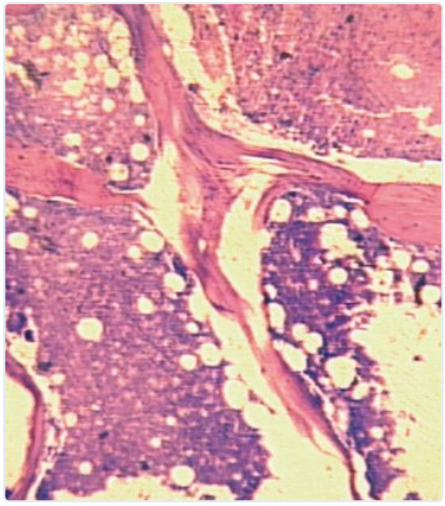
Media · Pancitopenia sin esplenomegalia, biopsia de médula ósea con celularidad < 25%

1.08.1.008 Hipofunción medular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Efectos mielotóxicos de drogas y medicamentos · Biopsia de médula ósea

LO QUE TE PREGUNTAN

- La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<**25%** celularidad).
- **Signo semiológico de valor diagnóstico crucial**: la aplasia medular NO presenta esplenomegalia ni adenopatías.
- Si hay pancitopenia con esplenomegalia palpable, sospechar hiperesplenismo, cirrosis, leucemia o mielofibrosis.
- **Fármacos clásicos inductores de aplasia**: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol), carbamazepina y quimioterapia.
- **Criterios de gravedad de Camitta**: neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL o reticulocitos < 20.000/uL.
- El tratamiento definitivo en pacientes jóvenes (< **40-50 años**) es el trasplante alogénico de médula ósea con donante HLA compatible.



MÉDULA NORMAL
Manual AMIR Hematología, p. 26

ALGORITMO · PANCITOPENIA EN EL ADULTO: SOSPECHA DE APLASIA MEDULAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

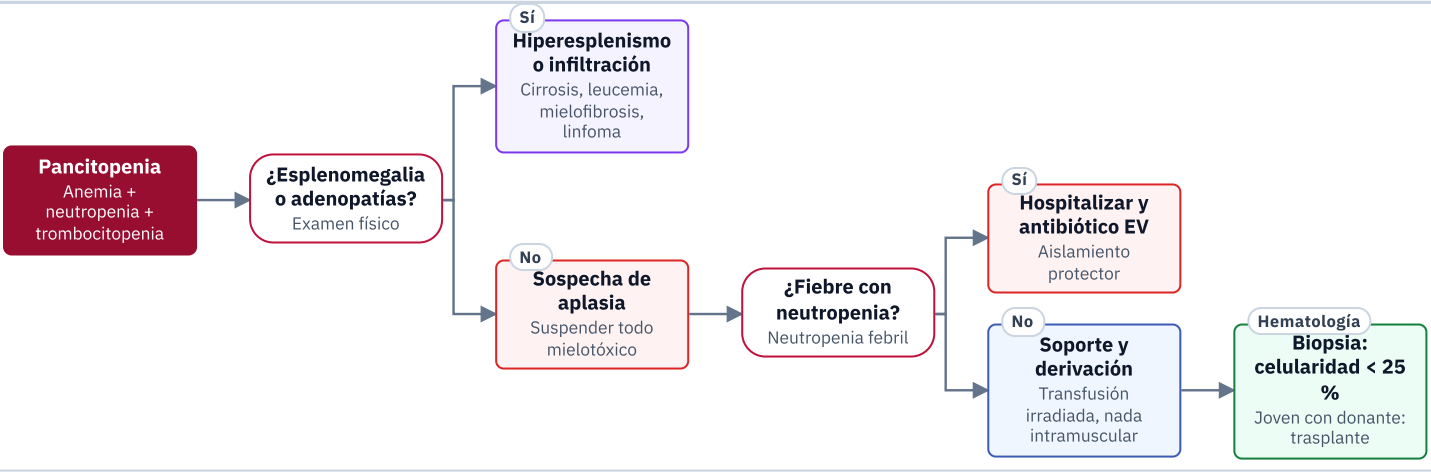


TABLA 8.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PANCITOPENIA EN SANGRE PERIFÉRICA

PATOLOGÍA	MÉDULA ÓSEA	ESPLENOMEGALIA	FROTIS PERIFÉRICO	CLAVE DIAGNÓSTICA
Aplasia Medular Adquirida	Hipocelular (<25%), infiltrada por grasa	Ausente (0%)	Pancitopenia sin anomalías morfológicas	Médula vacía sin organomegalia ni blastos
Leucemia Aguda (LMA / LLA)	Hipercelular con > 20% de blastos	Frecuente (especialmente LLA)	Blastos circulantes, bastones de Auer en LMA	Pancitopenia con blastos en frotis periférico
Síndrome Mielodisplásico	Normo o hipercelular con dishemopoyesis	Rara o ausente	Anisocitosis, hipogranulación, neutrófilos Pelger	Displasia celular multilínea en adultos mayores
Mielofibrosis Primaria	Fibrosis reticulínica severa (biopsia seca)	Esplenomegalia masiva	Dacriocitos (células en lágrima), leucoeritroblastosis	Punción aspirativa seca + dacriocitos + bazo gigante
Cirrosis con Hiperesplenismo	Médula normal o hiperplásica reactiva	Presente (Hipertensión portal)	Macrocitosis leve por alcoholismo / daño hepático	Estigmas de hepatopatía crónica + esplenomegalia

REGLA DE ORO **Pancitopenia sin organomegalia** — Aplasia hasta demostrar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **17–18** (pág. 8) · solucionario pág. 23.

Clase 8.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

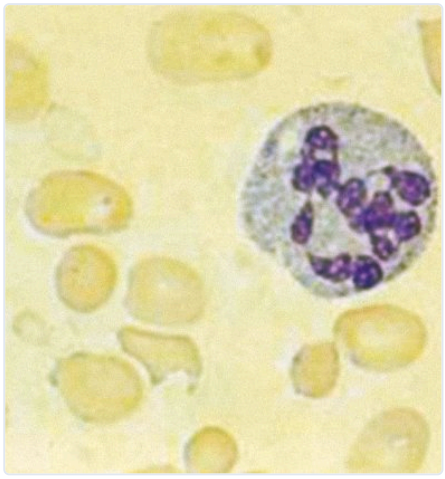
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.004 Anemia megaloblástica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Alcoholismo y asociación con carencias nutricionales · Síndromes sensitivos (polineuropatía, hemihipoestesia, dolor talámico, etc)

LO QUE TE PREGUNTAN

- El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.
- La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.
- **Peligro de examen**: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.
- La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.
- La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.



FROTIS MEGALOBLÁSTICO
Manual AMIR Hematología, p. 29

ALGORITMO · ANEMIA MACROCÍTICA: B12, FOLATO Y LA TRAMPA DEL ÁCIDO FÓLICO

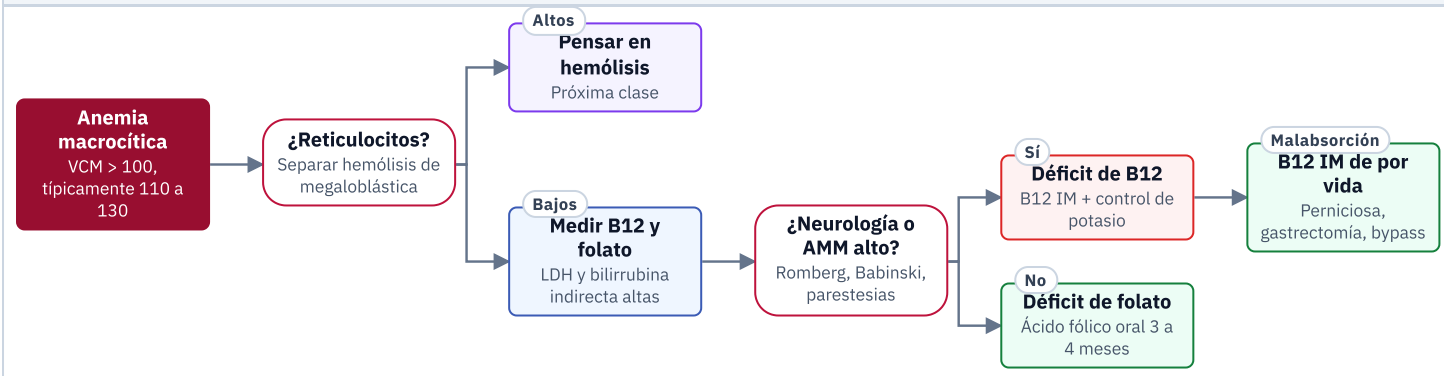


TABLA 8.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DÉFICIT DE VITAMINA B12 VS DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO

CARACTERÍSTICA	DÉFICIT DE VITAMINA B12 (COBALAMINA)	DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS)
Fuente Nutricional	Exclusivamente origen animal (carnes, huevos, lácteos)	Vegetales verdes frescos, legumbres, cítricos, hígado
Sitio de Absorción	Íleon terminal (unido obligatoriamente a Factor Intrínseco)	Yeyuno proximal (absorción activa y pasiva rápida)
Tiempo de Agotamiento	3 a 5 años (reservas hepáticas masivas: 3-5 mg)	3 a 4 meses (reservas hepáticas escasas: 5-10 mg)
Compromiso Neurológico	Presente: Degeneración combinada subaguda, ataxia, parestesias	Ausente por completo (no causa daño medular mielínico)
Ácido Metilmalónico Sérico	Marcadamente ELEVADO (Patognomónico del déficit de B12)	Estrictamente NORMAL
Homocisteína Plasmática	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)
Etiología Principal	Anemia perniciosa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal	Alcoholismo crónico, desnutrición, metotrexato, embarazo
Tratamiento Estándar	Cianocobalamina 1.000 ug IM (mensual de por vida si malabsorción)	Ácido fólico 1 a 5 mg/día vía oral durante 3 a 4 meses

REGLA DE ORO **VCM > 110, LDH alta, reticulocitos bajos** — Hemólisis intramedular, no periférica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **21–28** (págs. 8–9) · solucionario págs. 25–26.

Clase 8.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

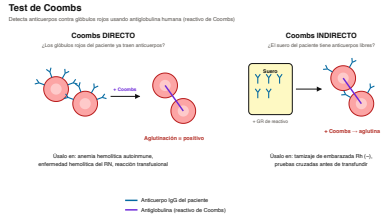
Alta · Tríada de hemólisis (ictericia, anemia, orina oscura), Coombs directo, corticoterapia de 1ª línea y rituximab

1.08.1.003 **Anemia hemolítica** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Pruebas de hemólisis

LO QUE TE PREGUNTAN

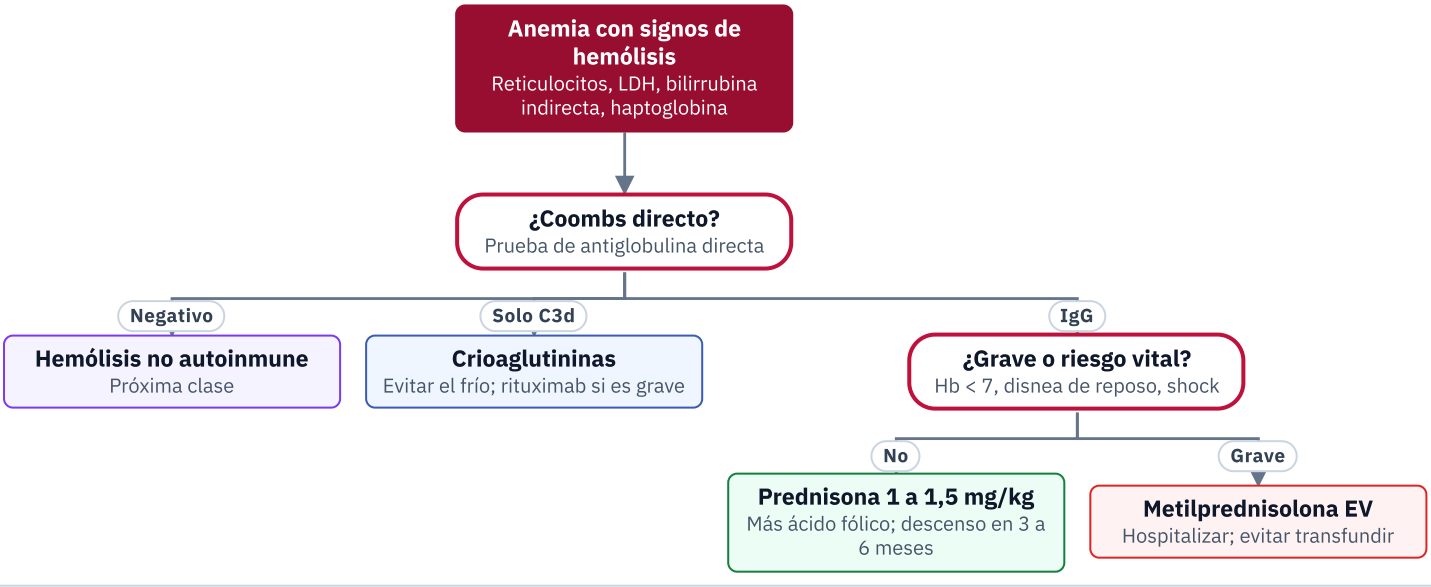
- **Tríada cardinal de hemólisis**: anemia regenerativa (reticulocitos >**2%**), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.
- La haptoglobina colapsada (< **10 mg/dL**) es el marcador más sensible de hemólisis intravascular y extravascular masiva.
- La Prueba de Coombs Directa positiva para IgG confirma AHAI por anticuerpos calientes (extravascular en bazo).
- El tratamiento de primera línea para AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica (prednisona **1-1.5 mg/kg**/día).
- En AHAI caliente todas las unidades de banco de sangre resultan "incompatibles"; solo transfundir ante compromiso vital inminente.
- La AHAI por crioaglutininas (IgM / C3d) no responde a corticoides ni esplenectomía; se maneja evitando el frío y con rituximab.
- Enfermedad por crioaglutininas se asocia a neumonía por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr y linfomas.



PRUEBA DE COOMBS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE: CONFIRMAR, CLASIFICAR Y TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **29–32** (págs. 9–10) · solucionario págs. 26–27.

Clase 8.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.7 · COMPARACIÓN INMUNOLÓGICA Y CLÍNICA: AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS

PARÁMETRO	AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES	ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS (FRÍOS)
Frecuencia Relativa	80% a 90% de todos los casos de AHAI	10% a 15% de los casos
Isotipo de Autoanticuerpo	IgG monomérico (rara vez IgA)	IgM pentamérico fijador de complemento
Temperatura Óptima	37 °C (temperatura corporal central)	0 °C a 4 °C (temperatura en lechos acrales fríos)
Sitio Principal de Lisis	Extravascular en Bazo (por macrófagos Fc-gamma)	Intravascular periférica y Extravascular en Hígado (C3b)
Frotis Sanguíneo	Microesferocitos abundantes, policromatofilia	Aglutinación de hematíes en pilas ("rouleaux anómalo")
Resultado Coombs Directo	Positivo para IgG (+/- complemento C3d)	Positivo exclusivamente para C3d (IgG negativo)
Asociaciones Clínicas	Idiopática, LES, LLC, linfomas, fármacos (cefalosporinas)	Mycoplasma pneumoniae, VEB (mononucleosis), linfoma B
Tratamiento de 1ª Línea	Corticoides sistémicos (Prednisona 1-1.5 mg/kg/día)	Evitar el frío ambiental estrictamente; Rituximab (No esteroides)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	AHAI CALIENTE	CRIOAGLUTININAS
Anticuerpo y temperatura	IgG a 37 °C	IgM a 0–4 °C
Transfusión	Solo con riesgo vital	Pruebas cruzadas siempre incompatibles

REGLA DE ORO **Reticulocitos altos, LDH alta** — Bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) representa una de las emergencias médicas más desafiantes en medicina interna. El EUNACOM exige el reconocimiento instantáneo del patrón biológico de hemólisis (reticulocitos altos, hiperbilirrubinemia indirecta, LDH marcadamente elevada y colapso de la haptoglobina plasmática). La Prueba de Coombs Directa es el examen confirmatorio de elección para AHAI por anticuerpos calientes. El médico general debe dominar el inicio precoz de corticoides sistémicos y recordar la máxima advertencia transfusional: las pruebas cruzadas siempre serán incompatibles, por lo que la transfusión de glóbulos rojos se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica vital.

TABLA 8.7.B · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR IGG

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / PROCEDIMIENTO	DOSIS Y MECANISMO	EFICACIA Y TIEMPO DE RESPUESTA
Primera Línea Estándar	Prednisona vía oral	1.0 a 1.5 mg/kg/día (disminución lenta en 3-6 meses)	Respuesta en 70-80% de casos al cabo de 1 a 2 semanas
Primera Línea Urgencia	Metilprednisolona endovenosa	Pulsos de 500 a 1.000 mg/día EV por 3 días consecutivos	Acción rápida en crisis hemolítica aguda descompensada
Segunda Línea Monoclonal	Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m² EV semanal por 4 semanas (elimina linfocitos B)	Respuesta en 70-90% de corticorrefractarios en 3-6 semanas
Segunda Línea Quirúrgica	Esplenectomía laparoscópica	Resección del bazo (elimina el sitio de hemólisis extravascular)	Remisión en 60-70%; exige vacunación contra encapsulados
Soporte Hematopoyético	Ácido Fólico vía oral	5 mg/día VO permanente durante la fase hemolítica activa	Previene crisis megaloblástica por consumo de folatos

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **29–32** (págs. 9–10) · solucionario págs. 26–27.

Clase 8.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

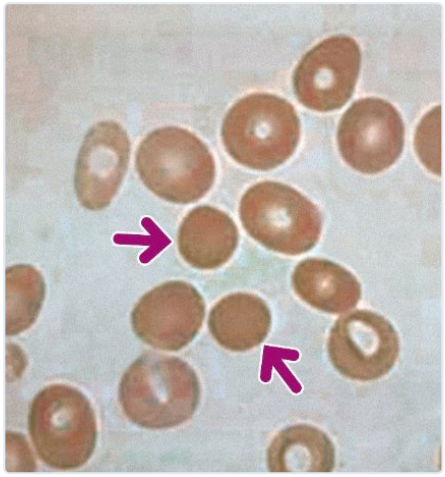
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Pruebas de hemólisis

LO QUE TE PREGUNTAN

- La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.
- **Tríada de esferocitosis**: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y esplenomegalia con Coombs negativo.
- El aumento de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > **36 g/dL**) es patognomónico de esferocitosis.
- El tratamiento curativo de la esferocitosis es la esplenectomía electiva, siempre diferida > **5 años** y posvacunación.
- **Déficit de G6PD**: ligado al X, cursa con cuerpos de Heinz y células mordidas tras habas, primaquina o sulfonamidas.
- La medición cuantitativa de G6PD debe realizarse varias semanas después de la crisis hemolítica aguda.



ESFEROCITOS
Manual AMIR Hematología, p. 34

ALGORITMO · ANEMIA HEMOLÍTICA: DEL COOMBS AL DEFECTO INTRÍNSECO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

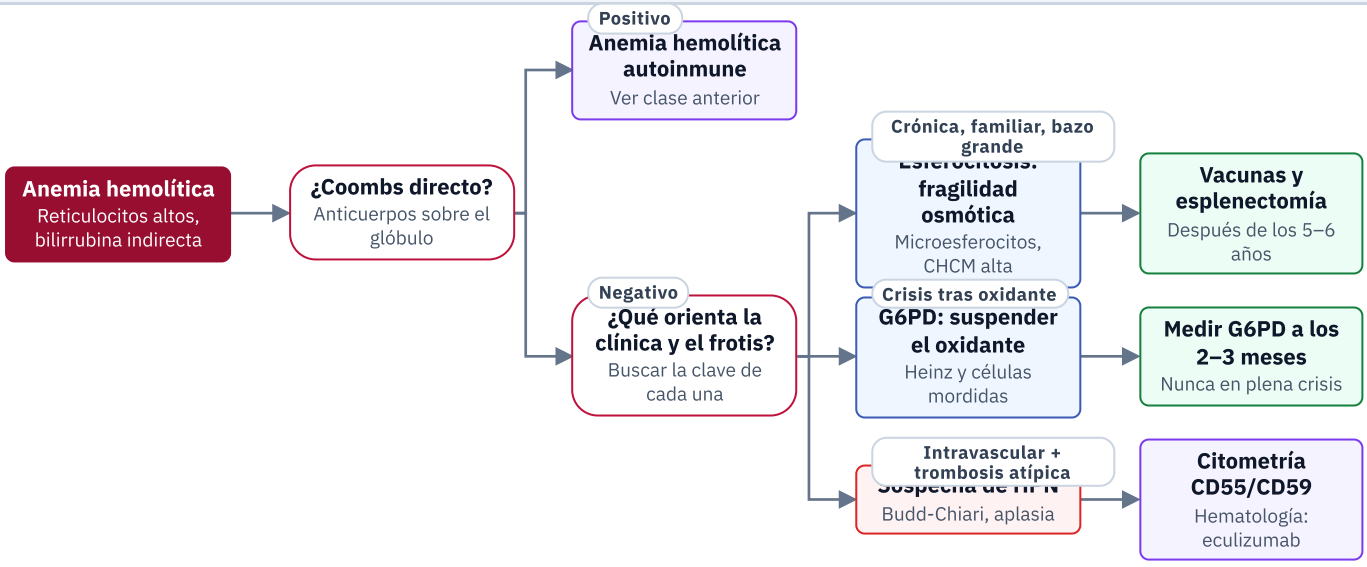


TABLA 8.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ESFEROCITOSIS HEREDITARIA VS DÉFICIT DE G6PD VS HPN

CRITERIO	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	DÉFICIT DE G6PD	HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Mecanismo Patogénico	Defecto citoesqueleto (anquirina/espectrina)	Déficit enzimático (defensa antioxidante)	Mutación somática gen PIGA (déficit anclaje GPI)
Patrón de Herencia	Autosómica dominante (75%)	Recesiva ligada al cromosoma X	Adquirida clonal no hereditaria
Hallazgo en Frotis	Microesferocitos densos, sin halo central	Cuerpos de Heinz y células mordidas (degmacitos)	Pancitopenia leve a moderada sin anomalía morfológica
Test Confirmatorio	Prueba Fragilidad Osmótica / Eosina-5-maleimida	Dosificación enzimática cuantitativa de G6PD	Citometría de flujo para CD55 y CD59
Clave Clínica de Examen	Colelitiasis en adolescente + bazo palpable + CHCM ↑	Crisis hemolítica tras habas, sulfas o primaquina	Hemólisis intravascular + trombosis atípica (Budd-Chiari)
Terapia Específica	Esplenectomía electiva (posvacunación encapsulados)	Evitar oxidantes (habas/fármacos); soporte en crisis	Eculizumab (anti-C5) / Trasplante alogénico

REGLA DE ORO **Colelitiasis joven + bazo + CHCM alta** — Confirmar con fragilidad osmótica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **33–34** (pág. 10) · solucionario págs. 27–28.

Clase 8.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

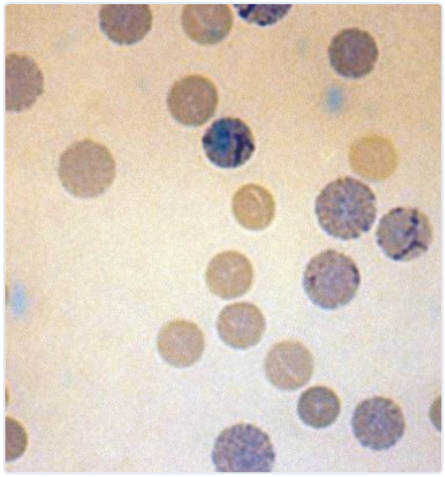
8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Rasgo talasémico menor**: microcitosis extrema (VCM < 70) con GR elevados (>5 mill), RDW normal y ferritina normal.
- **Índice de Mentzer**: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.
- La confirmación diagnóstica del rasgo talasémico beta se realiza con electroforesis de hemoglobina: HbA2 > **3.5%**.
- **¡Error grave EUNACOM!**: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis secundaria innecesaria.
- La drepanocitosis se debe a sustitución de ácido glutámico por valina en la cadena beta (HbS), polimerizando en hipoxia.
- **Complicaciones de la drepanocitosis**: crisis vasooclusivas dolorosas, síndrome torácico agudo y autoesplenectomía.



CUERPOS DE HEMOGLOBINA H
Manual AMIR Hematología, p. 37

ALGORITMO · MICROCITOSIS: ¿FERROPENIA O RASGO TALASÉMICO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

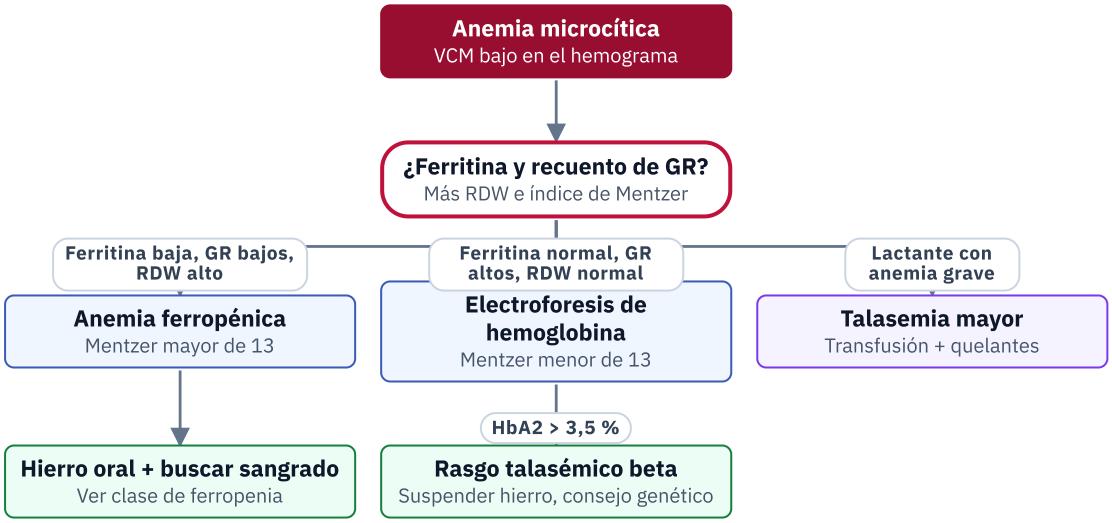


TABLA 8.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS RASGO TALASÉMICO MENOR

PARÁMETRO ANALÍTICO	ANEMIA FERROPÉNICA	RASGO TALASÉMICO BETA MENOR
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	Disminuido (< 80 fL), proporcional a la anemia	Marcadamente disminuido (< 70 fL), desproporcionado
Recuento de Glóbulos Rojos	Disminuido (< 4.0 millones/uL)	Normal o Aumentado (> 5.0 a 5.5 millones/uL)
Índice de Mentzer (VCM / Millones GR)	> 13 (orienta a ferropenia)	< 13 (orienta fuertemente a talasemia)
Amplitud Distribución Eritrocitaria (RDW)	Elevada (> 15%, anisocitosis marcada)	Normal (11.5 a 14.5%, microcitosis homogénea)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Estrictamente normal o ligeramente aumentada
Electroforesis de Hemoglobina	Normal (HbA1 97%, HbA2 < 3%)	Elevación de Hemoglobina A2 (> 3.5%)
Conducta Terapéutica	Suplementar con hierro oral y buscar causa sangrado	Asesoría genética; ¡Contraindicado dar hierro oral!

REGLA DE ORO **Microcitosis desproporcionada** — GR altos, RDW y ferritina normales

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **35–36** (pág. 10) · solucionario págs. 28–29.

Clase 8.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.012 Púrpuras trombopénicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome hemolítico urémico · Anemia hemolítica

LO QUE TE PREGUNTAN

- La PTT se produce por déficit severo (<**10%**) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.
- **Bíada suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT**: anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia de consumo.
- **Péntada clásica de Moschcowitz**: plaquetopenia, anemia con esquistocitos, clínica neurológica, fiebre y falla renal.
- **Diferencia clave con la CID**: en la PTT y en el SHU el TP, el TTPK y el fibrinógeno son rigurosamente NORMALES.
- El tratamiento de emergencia vital de la PTT es la Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario) más corticoides.



PETEQUIAS
Manual AMIR Hematología, p. 89

ALGORITMO · SOSPECHA DE MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

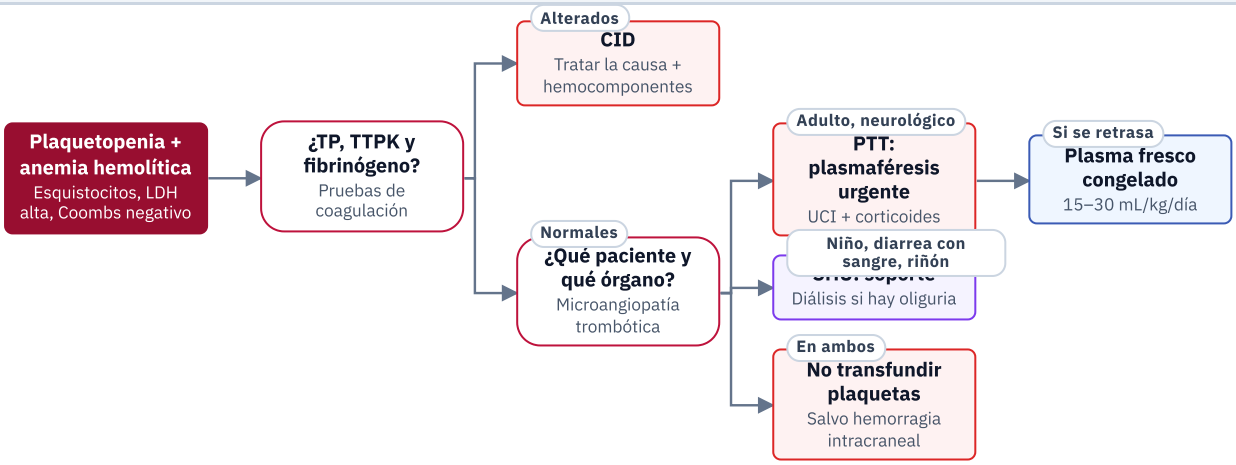


TABLA 8.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTT VS SHU TÍPICO VS COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

PARÁMETRO	PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)	SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)	COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)
Población Típica	Adultos (predominio mujeres jóvenes 20-50 años)	Pediátrica (lactantes y niños pequeños 1-5 años)	Cualquier edad en paciente crítico séptico / politraumatizado
Mecanismo Central	Déficit severo de ADAMTS13 (<10%) por autoanticuerpos	Daño endotelial por Toxina Shiga (E. coli O157:H7)	Activación masiva de trombina y consumo de factores
Órgano Dominante	Sistema Nervioso Central (fluctuante, afasia, coma)	Riñón (injuria renal aguda oligoanúrica grave)	Sistémico multiorgánico (hemorragia + trombosis microvascular)
Pruebas Coagulación (TP / TTPK)	ESTRICTAMENTE NORMALES (no se consumen factores)	ESTRICTAMENTE NORMALES	PROLONGADAS (TP ↑, TTPK ↑, Fibrinógeno ↓, Dímero D ↑↑)
Esquistocitos en Frotis	Presentes y abundantes (> 1-2%)	Presentes y abundantes	Presentes en cantidad variable
Tratamiento Cardinal	Plasmaféresis diaria urgente + Corticoides + Rituximab	Soporte hidroelectrolítico + diálisis si oliguria	Tratar la sepsis/causa + Hemocomponentes (PFC/crioprecipitado)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	PTT	SHU TÍPICO	CID
Paciente	Adulto, mujer 20–50 años	Niño de 1–5 años	Crítico: sepsis, trauma
Error frecuente	Transfundir plaquetas	Transfundir plaquetas	Olvidar la causa

REGLA DE ORO **Esquistocitos + plaquetas bajas** — Basta para sospechar una MAT

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **19–20** (pág. 8) · solucionario pág. 24.

Clase 8.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

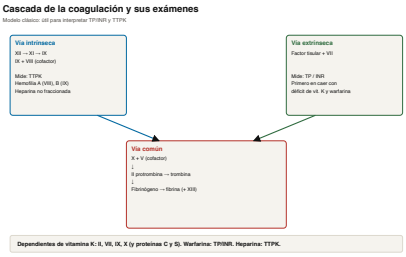
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.08.4.005 **Estudio de coagulopatías** — Interpreta y emplea

También: Estudio de trombopatías · Pruebas de coagulación

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hemostasia primaria (plaquetas/vWF)**: sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).
- **Hemostasia secundaria (factores)**: sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).
- El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.
- El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (**4-6 h**), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.
- El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.
- **La Prueba de Mezcla 1**:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).



VÍAS Y EXÁMENES
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · PRUEBAS DE COAGULACIÓN: LEER EL PATRÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

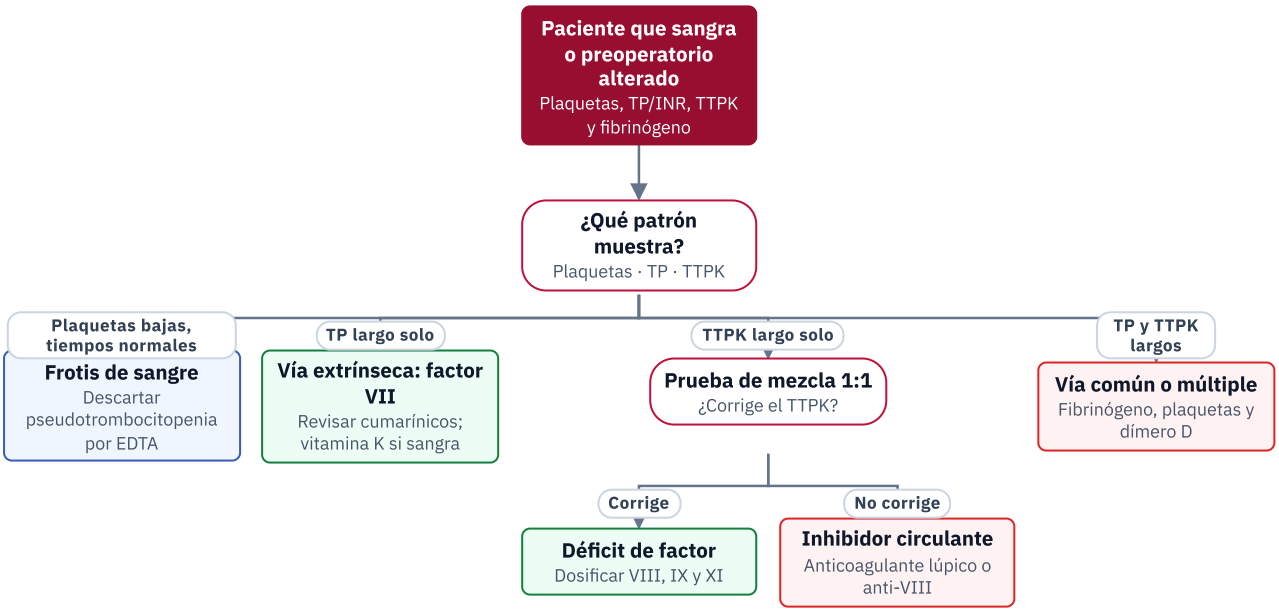


TABLA 8.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES EN LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN

PATRÓN ANALÍTICO	VÍA DE COAGULACIÓN AFECTADA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES FRECUENTES	CONDUCTA DIAGNÓSTICA INMEDIATA
TP prolongado / TTPK normal	Vía Extrínseca (Factor VII)	Uso de Cumarínicos (Acenocumarol), Déficit inicial Vitamina K, Hepatopatía leve	Evaluar ingesta de fármacos; administrar Vitamina K si sangrado
TTPK prolongado / TP normal	Vía Intrínseca (VIII, IX, XI, XII)	Hemofilia A/B, Enf. von Willebrand, Heparina no fraccionada, Anticoagulante lúpico	Realizar Prueba de Mezcla 1:1; si corrige, dosificar factores VIII y IX
TP y TTPK ambos prolongados	Vía Común (X, V, II, I) o Múltiple	Hepatopatía crónica severa, CID, déficit masivo Vit K, sobredosis de ACODs (Rivaroxabán)	Dosificar Fibrinógeno, Plaquetas y Dímero D para descartar CID
Plaquetas bajas / TP y TTPK normales	Hemostasia Primaria exclusiva	Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), hiperesplenismo, toxicidad medular	Revisar frotis de sangre para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA

REGLA DE ORO **Petequias y mucosas: plaquetas** — Hemostasia primaria

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **39–40** (pág. 11) · solucionario pág. 30.

Clase 8.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

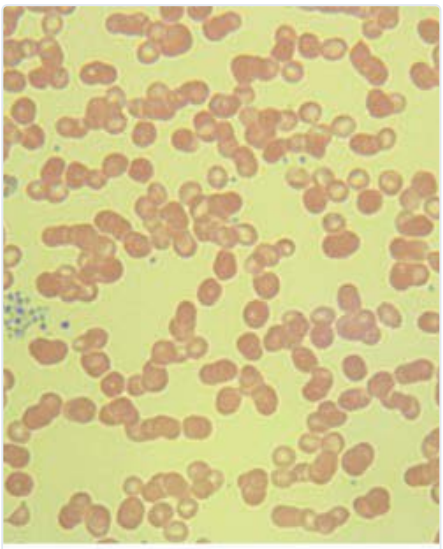
Máxima · Diagnóstico de exclusión en paciente con sangrado mucocutáneo sin esplenomegalia, corticoterapia e IgEV

1.08.1.012 **Púrpuras trombopénicos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Trombopenia severa · Síndrome purpúrico

LO QUE TE PREGUNTAN

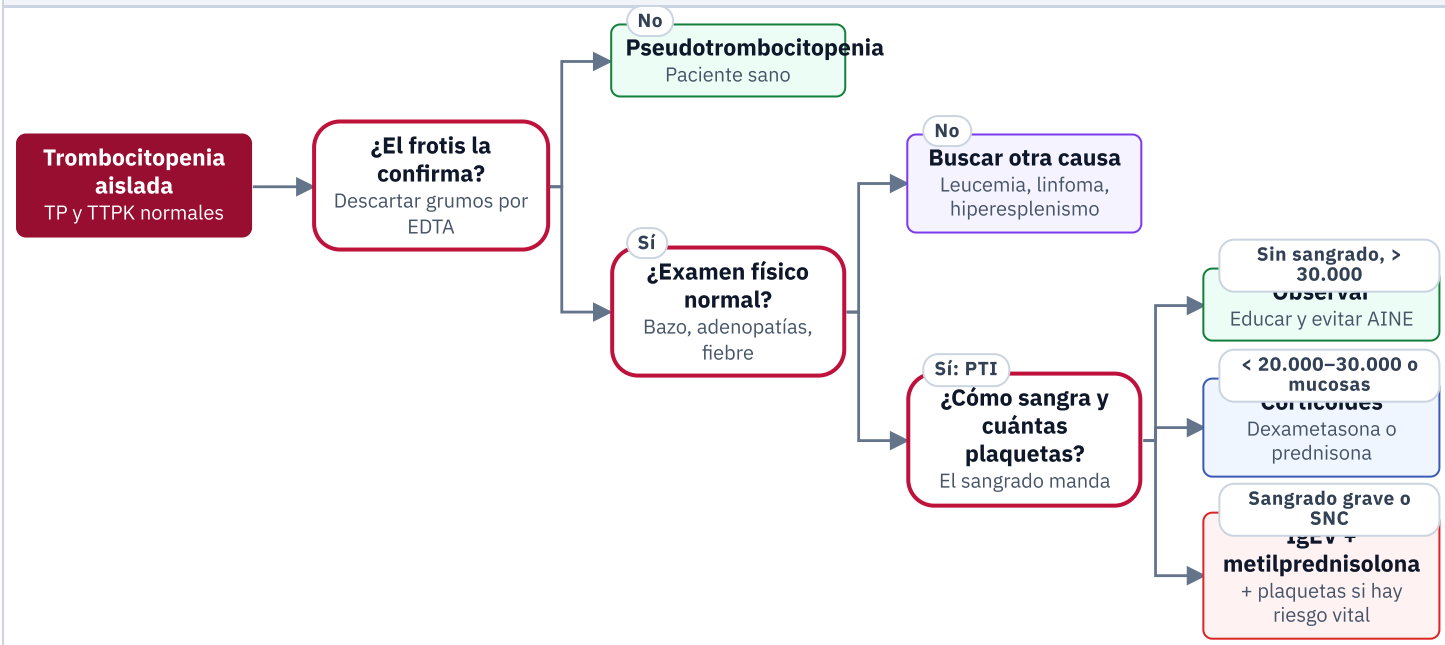
- **La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión**: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.
- Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados plaquetarios inducidos por EDTA.
- En niños es aguda, autolimitada tras virosis y remite espontáneamente en > **80%**; en adultos es crónica y progresiva.
- Pacientes asintomáticos con plaquetas > 30.000/uL NO requieren corticoides ni hospitalización; solo observación.
- **Indicación de tratamiento**: plaquetas < 20.000-30.000/uL o presencia de hemorragias mucocutáneas activas.
- **Primera línea**: Dexametasona **40 mg**/día x **4 días** o Prednisona **1 mg/kg**/día x **2-4 semanas**.
- La Inmunoglobulina EV (IgEV **1 g**/kg) es la terapia de rescate urgente por su ascenso plaquetario rápido en **24-48 horas**.



PSEUDOTROMBOCITOPENIA
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · TROMBOCITOPENIA INMUNE: DEL HEMOGRAMA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **38, 41–43** (pág. 11) · solucionario págs. 29, 31.

Clase 8.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.12 · COMPARACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO

CARACTERÍSTICA	PTI EN PEDIATRÍA (NIÑOS)	PTI EN ADULTOS
Edad Habitual de Presentación	Pico de incidencia entre 2 y 6 años de edad	Adultos jóvenes y medianos (18 a 40 años)
Predisposición por Sexo	Distribución igual entre niños y niñas (1:1)	Marcado predominio femenino (3:1 a 4:1)
Forma de Comienzo	Abrupta y explosiva (en horas o pocos días)	Insidiosa y progresiva (semanas a meses)
Antecedente Previo Gatillante	Presente en > 75% (infección viral respiratoria o exantema)	Habitualmente ausente (sin desencadenante reconocible)
Evolución Natural	Benigna y autolimitada: remisión espontánea en > 80%	Tendencia a la cronicidad en > 70-80% de los casos
Examen Físico Rector	Petequias y equimosis; Bazo NO palpable	Púrpura mucocutáneo; Bazo NO palpable
Conducta Terapéutica	Observación en la mayoría; tratar solo si sangrado mucoso	Tratar si plaquetas < 30.000 o sangrado: Corticoides/IgEV

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Trombocitopenia aislada en el hemograma	Frotis o repetir en citrato	Diagnosticar PTI sin frotis
Petequias + esplenomegalia o adenopatías	Buscar leucemia o linfoma	Llamarlo PTI
Niño post virosis, sin sangrado de mucosas	Observar: remite en > 80 %	Corticoides por el número

REGLA DE ORO **Primero el frotis** — Descartar pseudotrombocitopenia

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI, antes llamada idiopática) es el prototipo de trombocitopenia periférica por destrucción acelerada mediada por autoanticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias IIb/IIIa e Ib/IX. El EUNACOM interroga de forma incisiva sus diferencias según edad: en niños suele ser aguda, autolimitada y precedida por una infección viral respiratoria o exantema; en adultos es de inicio insidioso, crónica y con predominio femenino. El diagnóstico es estrictamente de exclusión (médula ósea normal o con megacariocitos aumentados y sin esplenomegalia palpable). Saber cuándo tratar con corticoides e IgEV y cuándo observar es un objetivo docente crítico.

TABLA 8.12.B · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / MODALIDAD	POSOLOGÍA ESTÁNDAR	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL
Primera Línea (Oral)	Prednisona vía oral	1 mg/kg/día por 2 a 4 semanas con desescalamiento lento	Disminuye destrucción esplénica y síntesis de anticuerpos
Primera Línea (Pulsos)	Dexametasona oral / EV	40 mg/día por 4 días consecutivos (ciclos cada 14-28 días)	Respuesta rápida con menor duración de exposición a esteroides
Rescate de Urgencia	Inmunoglobulina EV (IgEV)	1 g/kg/día por 1 a 2 días (infusión hospitalaria monitorizada)	Bloqueo competitivo agudo de receptores Fc en macrófagos
Segunda Línea (AR-TPO)	Eltrombopag (VO) / Romiplostim (SC)	Eltrombopag 25-75 mg/día oral en ayunas	Estimulación directa del receptor c-Mpl en megacariocitos
Segunda Línea (Monoclonal)	Rituximab endovenoso	375 mg/m² semanal durante 4 semanas consecutivas	Lisis y depleción de linfocitos B productores de anti-GPIIb/IIIa
Segunda Línea (Cirugía)	Esplenectomía laparoscópica	Cirugía electiva diferida > 12 meses tras vacunación	Resección del órgano rector de fagocitosis plaquetaria

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **38, 41–43** (pág. 11) · solucionario págs. 29, 31.

Clase 8.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

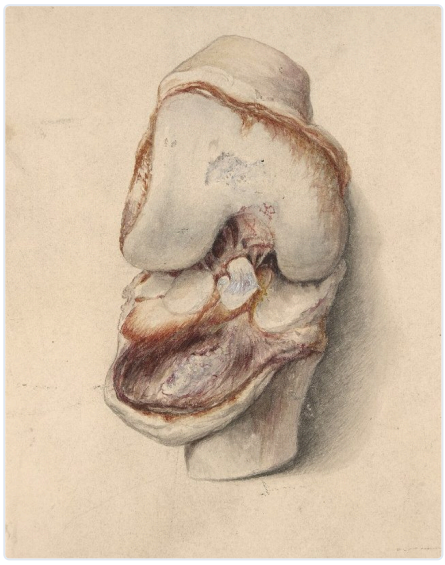
Muy Alta · Herencia recesiva ligada al X, hemartrosis, TTPK prolongado aislado, tratamiento sustitutivo con factor liofilizado

1.08.1.006 **Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand)** Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

También: Coagulopatía congénita sangrante · Estudio de coagulopatías · Trastornos coagulación

LO QUE TE PREGUNTAN

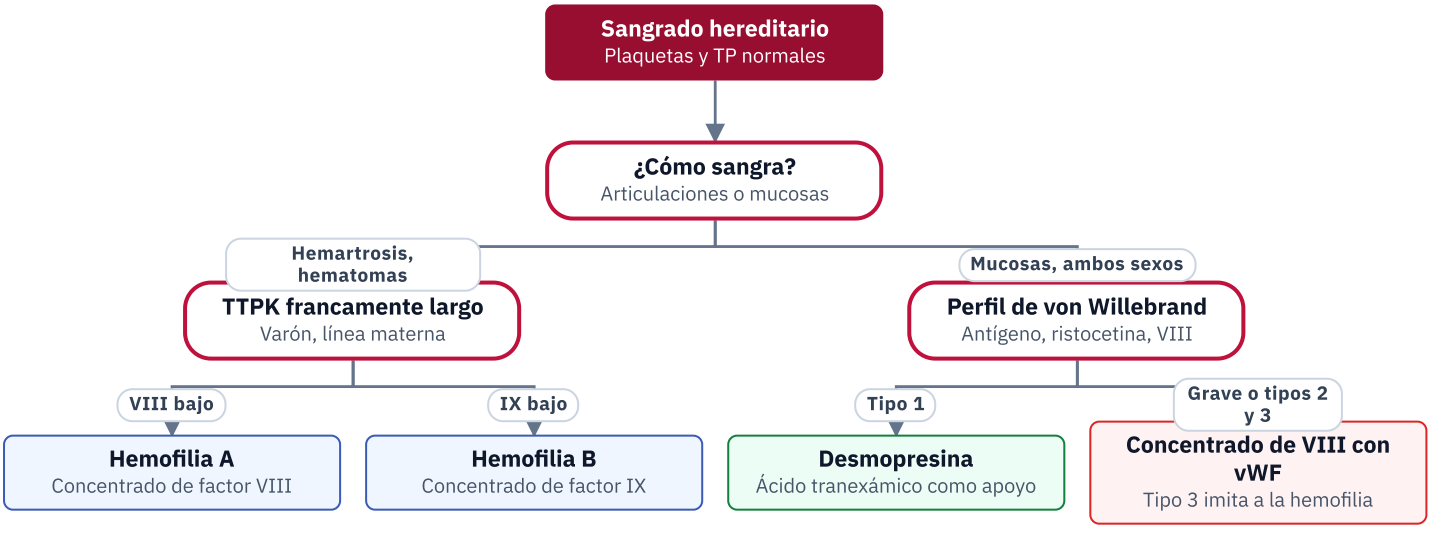
- **Hemofilia A (FVIII) y B (FIX)**: recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).
- La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la hemofilia severa.
- **Perfil hemostático de hemofilia**: plaquetas y TP normales, TTPK prolongado que corrige con plasma normal.
- Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; NUNCA realizar punción articular evacuadora.
- La Enfermedad de von Willebrand es autosómica dominante (afecta por igual a hombres y mujeres); sangrado mucocutáneo.
- Enfermedad de von Willebrand tipo 1 responde favorablemente a Desmopresina (DDAVP).
- **¡Contraindicaciones formales!**: NUNCA prescribir aspirina ni AINEs, ni realizar inyecciones intramusculares.



ARTROPATÍA HEMOFÍLICA
Wikimedia Commons «Knee joint of a haemophiliac Wellcome L0062595.jpg», CC BY 4.0, Godart, Thomas

ALGORITMO · COAGULOPATÍA CONGÉNITA: DE CÓMO SANGRA A QUÉ SE INFUNDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **44–49** (págs. 11–12) · solucionario págs. 31–33.

Clase 8.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 8.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOFILIA A VS HEMOFILIA B VS ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A	HEMOFILIA B	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (TIPO 1)
Herencia Genética	Recesiva ligada al cromosoma X	Recesiva ligada al cromosoma X	Autosómica dominante (cromosoma 12)
Población Afectada	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Ambos sexos por igual (hombres y mujeres)
Factor Deficiente	Factor VIII coagulante (F8)	Factor IX coagulante (F9)	Factor von Willebrand (vWF) cuantitativo
Manifestación Dominante	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia)
Tiempo de Protrombina (TP)	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL
TTPK / TTPA	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Variable: prolongado o normal (según FVIII)
Tratamiento Farmacológico	Concentrado de Factor VIII liofilizado (GES 32)	Concentrado de Factor IX liofilizado (GES 32)	Desmopresina (DDAVP) / Concentrado FVIII-vWF

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A Y B	VON WILLEBRAND TIPO 1
TP y plaquetas	Normales	Normales
Examen que confirma	Dosificar factores VIII y IX	Antígeno, ristocetina y VIII

REGLA DE ORO **Ligada al X, hemartrosis** — TTPK francamente largo

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las coagulopatías congénitas están cubiertas al 100% en Chile bajo el régimen GES N° 32 (Hemofilia). El EUNACOM evalúa: 1) La Hemofilia A (déficit de Factor VIII, 85% de los casos) y la Hemofilia B (déficit de Factor IX, 15%), transmitidas de forma recesiva ligada al cromosoma X, afectando clínicamente a varones con madres portadoras; 2) Las hemartrosis a repetición como manifestación distintiva que conduce a artropatía hemofílica invalidante; 3) La Enfermedad de von Willebrand como la diátesis hemorrágica hereditaria más común a nivel mundial (autosómica dominante con alteración de la hemostasia primaria y secundaria); y 4) La contraindicación formal de administrar aspirina, AINEs o realizar punciones articulares no cubiertas.

TABLA 8.13.B · PROTOCOLO DE MANEJO FARMACOLÓGICO Y CONTRAINDICACIONES EN HEMOFILIA

TIPO DE FÁRMACO / MEDIDA	NOMBRE GENÉRICO Y POSOLOGÍA	INDICACIÓN CLÍNICA PRECISA	PELIGRO / ADVERTENCIA EUNACOM
Terapia Sustitutiva FVIII	Concentrado FVIII recombinante 25-50 UI/kg EV	Hemartrosis, hematoma de psoas o sangrado en hemofilia A	Infusión precoz inmediata; no demorar esperando radiografías
Terapia Sustitutiva FIX	Concentrado FIX recombinante 40-100 UI/kg EV	Hemartrosis y sangrados en hemofilia B (Christmas)	Factor VIII es completamente inútil en hemofilia B
Secretagogo Endotelial	Desmopresina (DDAVP) 0.3 ug/kg EV en infusión salina	Enfermedad de von Willebrand tipo 1 y hemofilia A leve	Riesgo de hiponatremia por efecto antidiurético; limitar líquidos
Antifibrinolítico	Ácido Tranexámico 15-25 mg/kg VO o EV c/8h	Coadyuvante en sangrado mucoso oral o exodoncia dental	Contraindicado formalmente en hematuria macroscópica renal
Contraindicación Farmacológica	Aspirina y AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco, Ketorolaco)	¡PROHIBIDOS TOTALMENTE EN HEMOFILIA Y EvW!	Inhiben la hemostasia primaria y gatillan sangrado mortal
Contraindicación Procedimental	Inyecciones intramusculares y Artrocentesis articular	¡PROHIBIDAS SALVO PROTOCOLO ESTRICTO EN PABELLÓN!	Riesgo de hematoma sofocante y artritis séptica grave

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **44–49** (págs. 11–12) · solucionario págs. 31–33.

Clase 8.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.005 Coagulopatías adquiridas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Coagulopatía adquirida · Tratamiento anticoagulante · Interacción de drogas y anticoagulantes orales

LO QUE TE PREGUNTAN

- La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.
- El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K (diferencia daño hepático de déficit de vit K).
- **INR entre 4.5 y 10 sin sangrado**: suspender 1-2 dosis de acenocumarol; no requiere vitamina K de rutina.
- **INR > 10 sin sangrado**: suspender acenocumarol y administrar vitamina K1 oral a dosis bajas (**2.5 a 5 mg**).
- **Hemorragia grave con riesgo vital por cumarínicos**: Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) EV + Vitamina K **10 mg** EV.

ALGORITMO · CUMARÍNICO CON INR ALTO: QUÉ HACER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

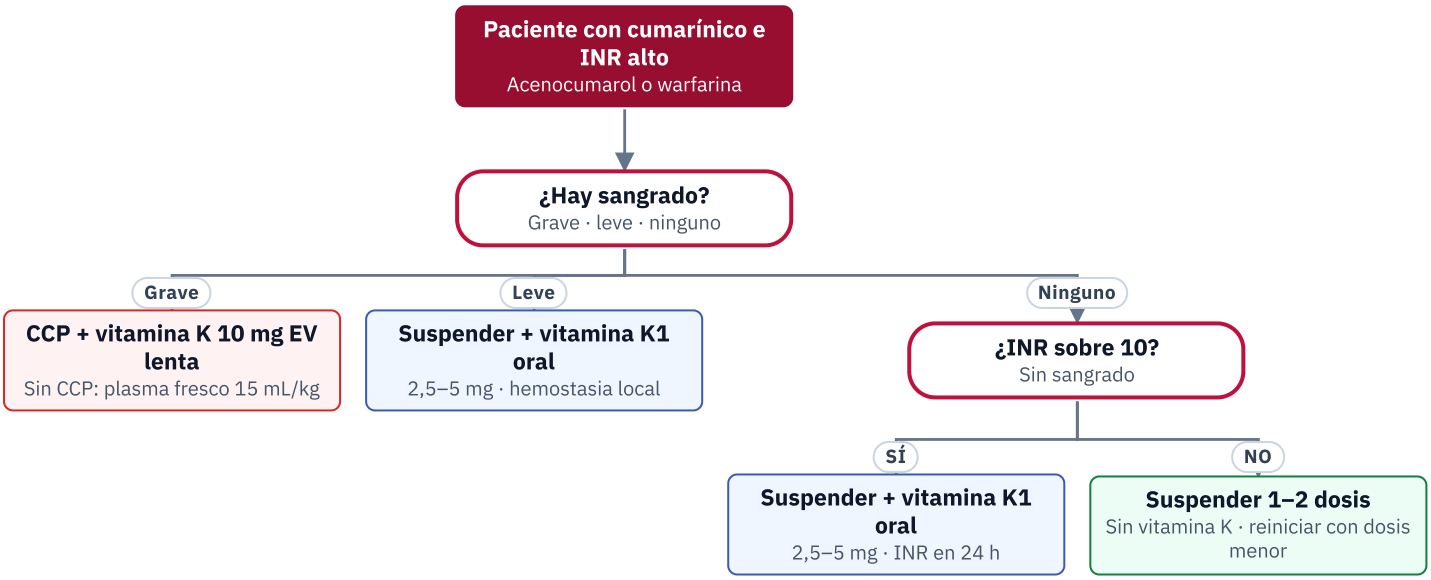


TABLA 8.14 · MANEJO ESCALONADO DE LA SOBREANTICOAGULACIÓN POR CUMARÍNICOS SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

NIVEL DE INR	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA RECOMENDADA	TIEMPO DE RESPUESTA
INR 4.5 a 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender 1 a 2 dosis; NO administrar vitamina K de rutina	Descenso paulatino en 24 a 48 horas
INR > 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Corrección de INR en 24 horas sin refractariedad
Cualquier INR	Hemorragia leve / mucocutánea	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Monitoreo y hemostasia local
Cualquier INR	Hemorragia grave o riesgo vital	Suspender + CCP 4 factores (25-50 UI/kg) EV + Vit K 10 mg EV	Reversión hemostática inmediata en 10-15 minutos (CCP)
Alternativa si no hay CCP	Hemorragia grave	Plasma Fresco Congelado (PFC 15 mL/kg) + Vitamina K 10 mg EV	Lenta (horas); riesgo de sobrecarga de volumen

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
TP largo con factor V bajo	Daño hepático crónico	Esperar corrección con vitamina K
Colestasis o antibióticos prolongados	Déficit de vitamina K	Pensar en hemofilia
Hemorragia mayor con dabigatrán	Idarucizumab	Protamina

REGLA DE ORO **Vitamina K activa II, VII, IX y X** — Y las proteínas C y S

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **50–52** (págs. 12–13) · solucionario págs. 34–35.

Clase 8.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.2.001 Coagulación intravascular diseminada — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Indicaciones de uso de componentes sanguíneos

LO QUE TE PREGUNTAN

- La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por consumo.
- **Causas clásicas**: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y politraumatismos graves.
- **Laboratorio clásico de CID**: plaquetas bajas + TP y TTPK prolongados + fibrinógeno colapsado (<100) + Dímero D altísimo.
- Score ISTH **≥ 5 puntos** confirma el diagnóstico de CID manifiesta descompensada.
- El tratamiento fundamental de la CID es tratar y erradicar la causa desencadenante de base.



PÚRPURA EN UNA SEPSIS
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 38

ALGORITMO · SOSPECHA DE CID: DEL SCORE A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

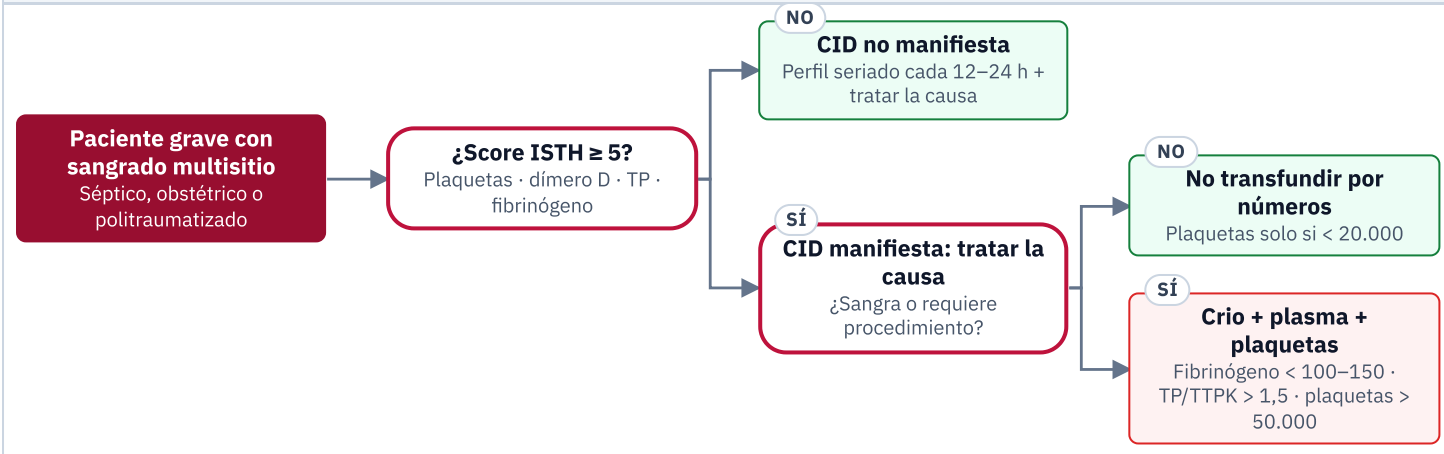


TABLA 8.15 · SCORE DIAGNÓSTICO DE CID MANIFIESTA DE LA ISTH (PUNTAJE ≥ 5 CONFIRMA CID)

PARÁMETRO ANALÍTICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO (SCORE ISTH)	SIGNIFICADO EN LA FISIOPATOLOGÍA
Recuento de Plaquetas	> 100.000: 0 pts | 50.000-100.000: 1 pt | < 50.000: 2 pts	Grado de consumo plaquetario periférico en microtrombos
Dímero D / PDF	Normal: 0 pts | Elevación moderada: 2 pts | Elevación severa: 3 pts	Intensidad de la fibrinólisis reactiva por plasmina
Tiempo de Protrombina (TP)	Prolongación < 3 seg: 0 pts | 3 a 6 seg: 1 pt | > 6 seg: 2 pts	Consumo de factores de coagulación de vía extrínseca/común
Concentración de Fibrinógeno	> 100 mg/dL: 0 pts | < 100 mg/dL: 1 pt	Agotamiento del sustrato final para la formación de fibrina
Puntaje Total ISTH	≥ 5 Puntos = CID Manifiesta compatible	Indica necesidad de soporte transfusional y monitorización

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	LABORATORIO	CLAVE
CID	Plaquetas bajas + TP y TTPK largos + fibrinógeno bajo + dímero D alto	Todo alterado a la vez
PTI	Solo plaquetas bajas	Coagulación normal
PTT y SHU	Plaquetas bajas + esquistocitos	TP y TTPK normales

REGLA DE ORO **Síndrome secundario** — Sepsis, obstetricia, trauma, M3

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **53–54** (pág. 13) · solucionario pág. 35.

Clase 8.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.009 Leucemias agudas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Mielograma · Leucemias · Quimioterapia intratecal

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterio rector de leucemia aguda según la OMS**: presencia de **≥ 20%** de blastos en médula ósea o sangre.
- Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.
- La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>**85%** curación).
- La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.
- La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.



INFILTRACIÓN GINGIVAL
Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 63

ALGORITMO · LEUCEMIA AGUDA: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

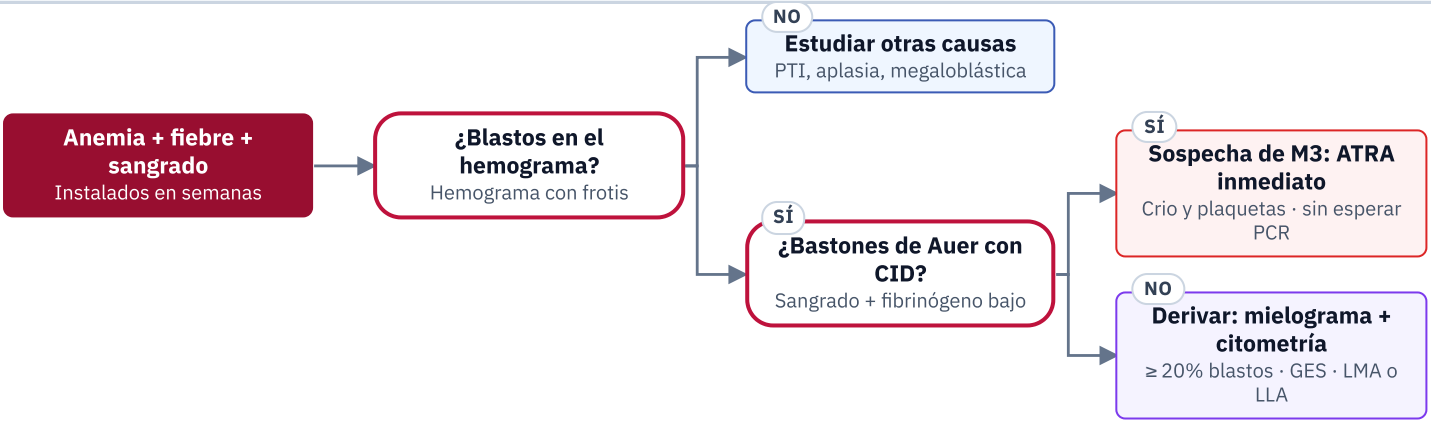


TABLA 8.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y BIOLÓGICO: LMA VS LLA

CARACTERÍSTICA	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA)	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
Población Predominante	Adultos mayores (mediana 68 años); 20% en niños	Pediátrica (pico 2 a 5 años); 20% en adultos
Morfología de Blastos	Células grandes, citoplasma amplio, gránulos azurófilos	Células medianas, citoplasma escaso, sin gránulos
Bastones de Auer	PRESENTES (Patognomónicos de LMA)	AUSENTES en el 100% de los casos
Citoquímica Enzimática	Mieloperoxidasa (MPO) POSITIVA, Sudán Negro (+)	MPO NEGATIVA; TdT POSITIVA en >95%
Inmunofenotipo Citometría	CD13 (+), CD33 (+), CD117 (+), MPO (+)	Estirpe B: CD19, CD10, CD22 | Estirpe T: CD3, CD7
Infiltración Tisular Clásica	Hiperplasia gingival, cloromas cutáneos (M4/M5)	Sistema nervioso central (meninges) y testículos
Emergencia Específica	LMA-M3: CID catastrófica -> Tratar con ATRA urgente	Síndrome de lisis tumoral agudo al iniciar quimio
Pronóstico Curativo Global	30% a 40% de sobrevida en adultos; peor en ancianos	> 85% a 90% de curación en niños (GES N° 8)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Anemia + fiebre + sangrado en semanas	Hemograma con frotis	Pensar solo en infección
Blastos en sangre periférica	Derivación urgente + mielograma	Controlar en unas semanas
Confirmación diagnóstica	Mielograma: ≥ 20% de blastos	Quedarse solo con el hemograma

REGLA DE ORO **Anemia + fiebre + sangrado en semanas** — Insuficiencia medular aguda

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **55–59** (págs. 13–14) · solucionario págs. 35–36.

Clase 8.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

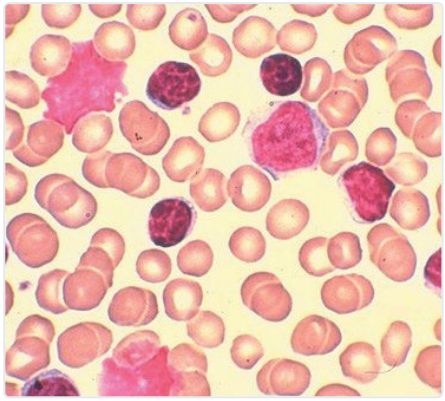
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.010 Leucemias crónicas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Reacción leucemoide

LO QUE TE PREGUNTAN

- La LMC se asocia en el **95%** al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.
- **Frotis de LMC**: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y eosinofilia característica.
- El tratamiento de elección en LMC son los Inhibidores de Tirosina Quinasa orales (Imatinib), garantizados en GES N° 37.
- La LLC es la leucemia más común del adulto mayor; se caracteriza por linfocitosis B madura clonal (CD19+/CD5+).
- Las Sombras de Gümprecht (manchas de lisis nuclear por fragilidad en frotis) son patognomónicas de la LLC.



SOMBRAS DE GÜMPRECHT
Goljan, Rapid Review Pathology, Link 13-19

ALGORITMO · LEUCEMIAS CRÓNICAS: DEL HEMOGRAMA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

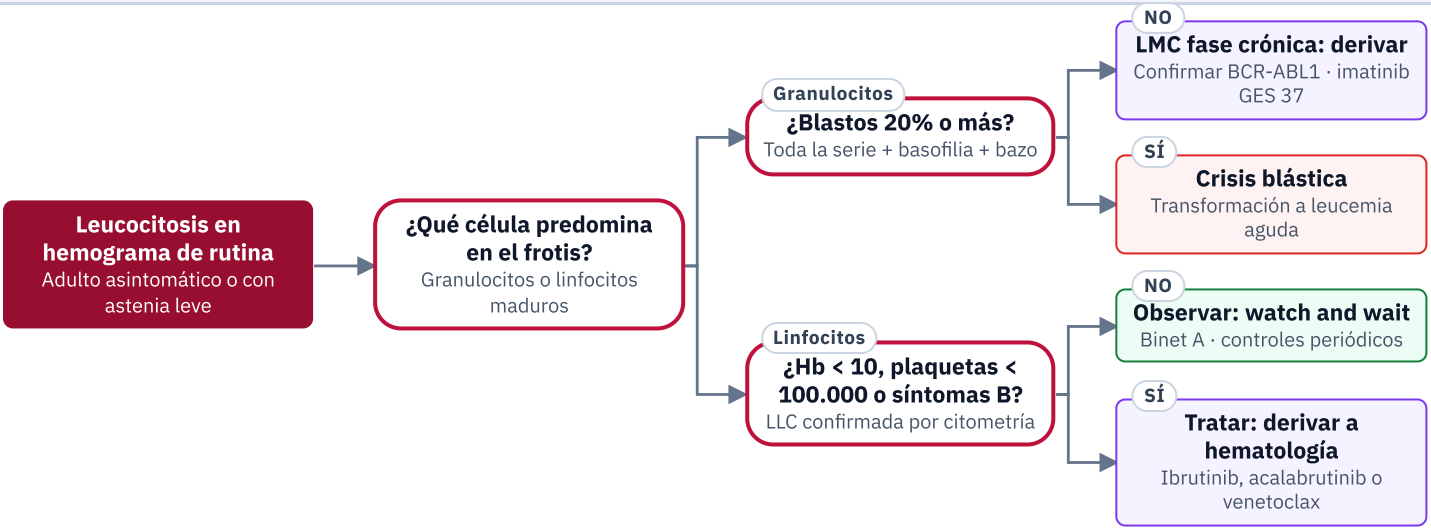


TABLA 8.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) VS LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)

PARÁMETRO	LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC)	LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)
Población Típica	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores y ancianos (> 70 años)
Serie Proliferante	Mieloide granulocítica completa (con basofilia)	Linfoide B madura monótona (CD19+, CD5+)
Frotis Sanguíneo	Mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados	Linfocitos maduros + Sombras de Gümprecht
Genética Marcadora	Cromosoma Filadelfia t(9;22) / Oncogén BCR-ABL1	Deleción 13q (buen pronóstico), del 17p / TP53 (mal pronóstico)
Signo Semiológico Clave	Esplenomegalia gigante indolora frecuente	Adenopatías generalizadas bilaterales e indoloras
Riesgo de Transformación	Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda)	Síndrome de Richter (transformación a linfoma difuso agresivo)
Conducta Inicial Estándar	Tratamiento inmediato con Imatinib (ITK) oral	Observación expectante ("Watch and Wait") en Binet A

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Leucocitosis, toda la serie, basofilia, bazo grande	LMC	Llamarla leucemia aguda por ver algún blasto
LMC confirmada	ITK oral: imatinib (GES 37)	Quimioterapia clásica
Anciano con linfocitosis y Gümprecht	LLC	Linfoma o LMC

REGLA DE ORO **Toda la serie + basofilia + bazo gigante** — Plaquetas normales o altas

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **60–62** (pág. 14) · solucionario pág. 37.

Clase 8.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.011
2.01.1.033
Linfomas

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Biopsia ganglionar · Radiografía de tórax · Linfomas cutáneos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Regla de oro**: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).
- **Síntomas B**: fiebre inexplicada > **38 °C**, sudoración nocturna profusa y baja de peso involuntaria > **10%** en **6 meses**.
- El Linfoma de Hodgkin presenta distribución bimodal (20-30 a y >60 a) y células binucleadas de Reed-Sternberg (CD30+/CD15+).
- El subtipo más común de Hodgkin es la Esclerosis Nodular (**70%**, mujeres jóvenes, masa mediastínica).
- **Diseminación de Hodgkin**: contigua y ordenada por estaciones linfáticas; diseminación de No Hodgkin: hematógena precoz.



ADENOPATÍA SUPRACLAVICULAR
Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 193

ALGORITMO · ADENOPATÍA SOSPECHOSA: DEL GANGLIO AL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

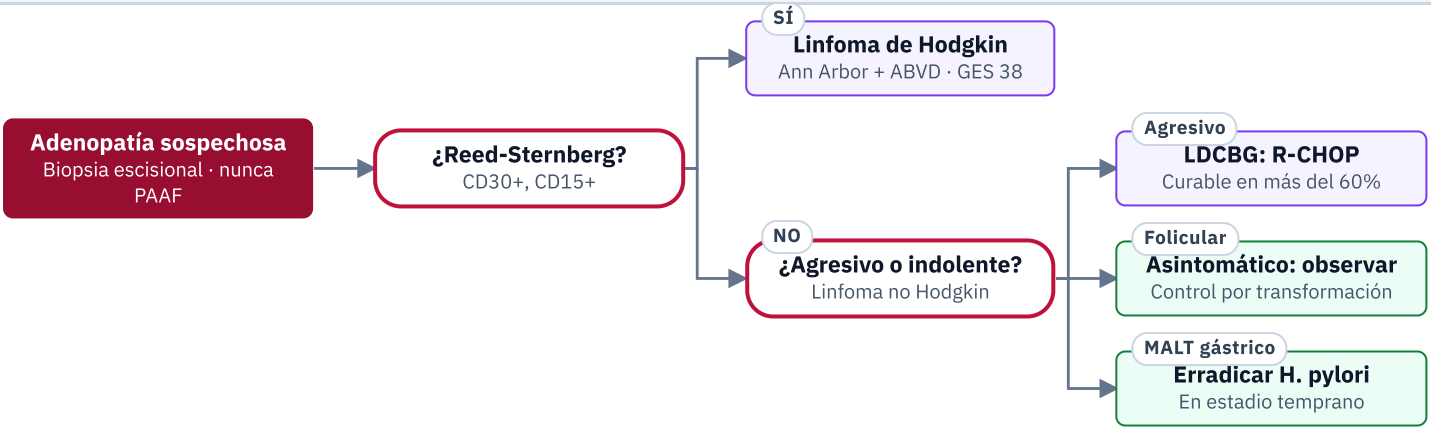


TABLA 8.18 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LINFOMA DE HODGKIN VS LINFOMAS NO HODGKIN

CARACTERÍSTICA	LINFOMA DE HODGKIN (LH)	LINFOMAS NO HODGKIN (LNH)
Distribución por Edades	Bimodal (picos a los 20-30 años y > 60 años)	Incidencia continuamente creciente con la edad (> 60 a)
Patrón de Diseminación	Ordenado, por contigüidad linfática anatómica	No contiguo, desordenado, diseminación hematógena precoz
Compromiso Extraganglionar	Muy raro en fases iniciales (< 5-10%)	Muy frecuente (> 30-40%: digestivo, SNC, piel, bazo)
Compromiso Mediastínico	Muy frecuente en subtipo Esclerosis Nodular (60%)	Menos común (salvo linfoma mediastínico primario B)
Célula Neoplásica Típica	Célula gigante de Reed-Sternberg (CD30+, CD15+)	Proliferación clonal homogénea de linfocitos B o T
Infiltrado Inflamatorio	Predominante (98% de la masa tumoral es reactiva)	Escaso (la masa está formada por células neoplásicas)
Curabilidad Global	Altamente curable (> 85% de curación con ABVD)	Curable en agresivos (LDCBG 60%); incurable en foliculares

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Adenopatía sospechosa de linfoma	Biopsia escisional del ganglio	PAAF
Joven con adenopatía y síntomas B	Linfoma, probable Hodgkin	Tuberculosis o mononucleosis
Definir síntomas B	Fiebre, sudoración, baja de peso > 10%	Incluir prurito o dolor con alcohol

REGLA DE ORO **Indolora, gomosa, > 2 cm, > 4–6 semanas** — Sospechar linfoma

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **63–65** (pág. 14) · solucionario pág. 38.

Clase 8.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

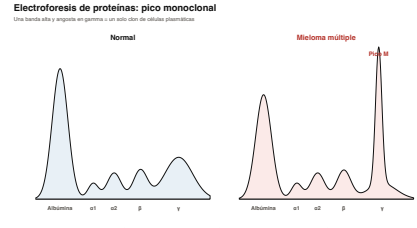
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.007 Disproteinemias (gammapatías M) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Electroforesis de proteínas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Nemotecnia CRAB**: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).
- VHS > **100 mm**/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente sugestiva de mieloma múltiple.
- La Electroforesis de Proteínas demuestra un pico monoclonal estrecho en región gamma (IgG **55%**, IgA **20%**).
- El "Riñón de Mieloma" se debe a la precipitación y obstrucción intratubular por cilindros de cadenas ligeras libres.
- **GMSI**: pico M < **3 g/dL**, plasmocitos medulares < **10%** y AUSENCIA de criterios CRAB (se observa anualmente).



ELECTROFORESIS CON PICO M
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · MIELOMA MÚLTIPLE: DEL PICO MONOCLONAL A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

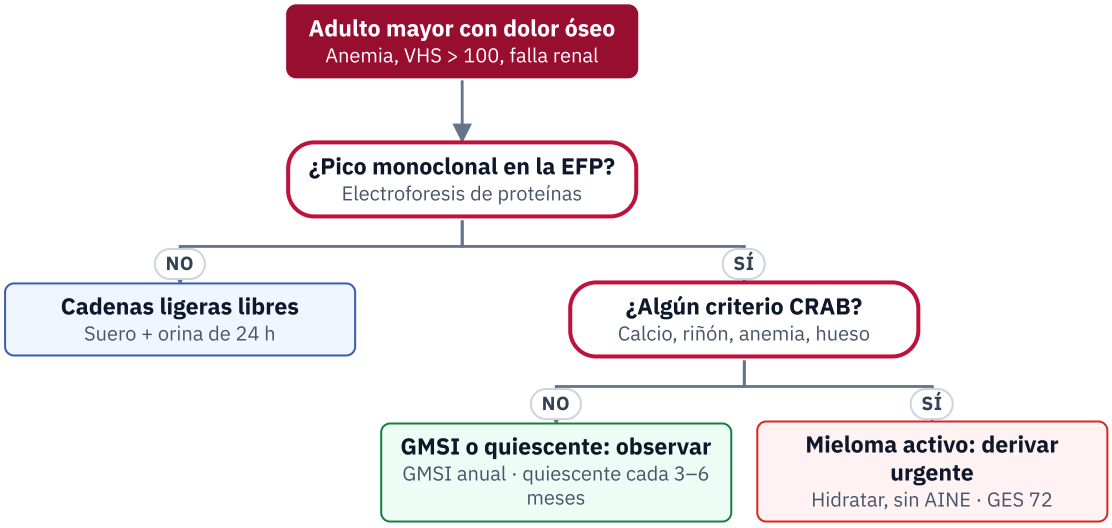


TABLA 8.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MIELOMA MÚLTIPLE VS GMSI VS MIELOMA QUIESCENTE (SMOLDERING)

CRITERIO DIAGNÓSTICO	GAMMAPATÍA MONOCLONAL INCIERTA (GMSI)	MIELOMA QUIESCENTE (ASINTOMÁTICO)	MIELOMA MÚLTIPLE ACTIVO (SINTOMÁTICO)
Componente M Sérico	< 3.0 g/dL	≥ 3.0 g/dL (o en orina ≥ 500 mg/24h)	Presente (cualquier nivel; habitualmente > 3 g/dL)
Plasmocitos en Médula Ósea	< 10% del total celular nucleado	10% a 59% de celularidad plasmática	≥ 10% (o plasmocitoma extramedular probado)
Criterios de Daño CRAB	RIGUROSAMENTE AUSENTES	RIGUROSAMENTE AUSENTES	AL MENOS 1 CRITERIO CRAB PRESENTE
Conducta Terapéutica	Observación ambulatoria anual; no tratar	Monitoreo estrecho cada 3-6 meses; no quimio	Tratamiento inmediato: Bortezomib + Lenalidomida + Dexa

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Adulto mayor: dolor óseo + anemia + falla renal + VHS > 100	Mieloma múltiple	Cáncer de próstata o renal metastásico
Pico M < 3 g/dL, plasmocitos < 10%, sin CRAB	GMSI: observar anualmente	Quimioterapia
Pico M con 1 criterio CRAB	Mieloma activo: tratar ya	Esperar y controlar

REGLA DE ORO **Calcio > 11 · creatinina > 2** — Hb < 10 · lesiones en sacabocado

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **66–69** (págs. 14–15) · solucionario pág. 39.

Clase 8.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndromes mielodisplásicos · Síndrome leucoeritroblástico

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >**95%** y EPO sérica suprimida.
- **Tríada clínica de PV**: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico tras ducha caliente.
- **Meta terapéutica fundamental en Policitemia Vera**: Hematocrito estrictamente < **45%** mediante flebotomías.
- Las poliglobulias secundarias cursan con EPO sérica elevada y JAK2 negativo (EPOC, apnea del sueño, fumador).
- **Mielofibrosis Primaria**: esplenomegalia gigante + dacriocitos (células en lágrima) en frotis + punción medular seca.

ALGORITMO · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS: QUÉ SERIE ESTÁ ALTERADA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

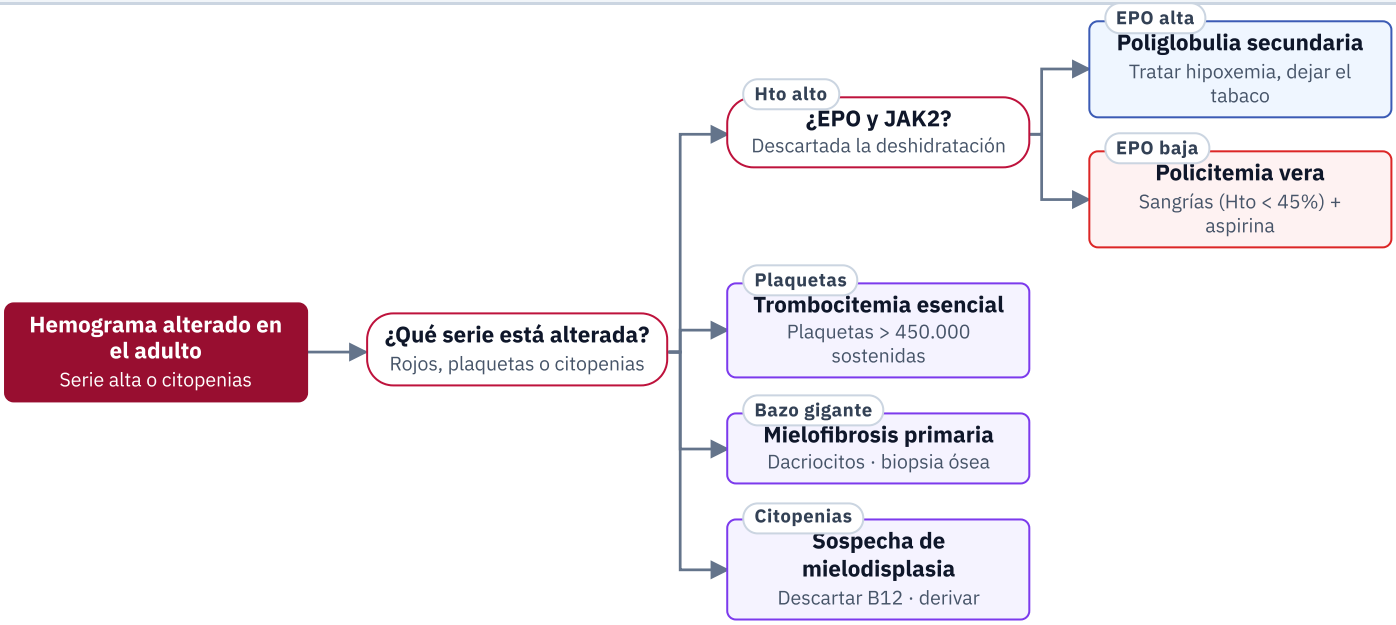


TABLA 8.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLICITEMIA VERA VS POLIGLOBULIAS SECUNDARIAS

CARACTERÍSTICA	POLICITEMIA VERA (NEOPLASIA PRIMARIA)	POLIGLOBULIA SECUNDARIA (HIPÓXICA O TUMORAL)
Mecanismo Patogénico	Proliferación clonal autónoma medular (JAK2)	Estimulación fisiológica o patológica por Eritropoyetina
Mutación JAK2 V617F	PRESENTE en > 95% a 98% de los casos	RIGUROSAMENTE NEGATIVA (0%)
Niveles de Eritropoyetina (EPO)	SUPRIMIDOS o Indetectables (< 2-4 mIU/mL)	ELEVADOS (> 20-100 mIU/mL)
Otras Series en Hemograma	Panmielosis: Leucocitosis y Trombocitosis asociadas	Glóbulos blancos y plaquetas normales
Esplenomegalia	Presente en > 70% de los pacientes	Ausente
Prurito Acuagénico	Muy característico (desencadenado por agua tibia)	Ausente
Etiologías Típicas	Neoplasia clonal hematopoyética primaria	EPOC severo, apnea del sueño, tabaquismo, carcinoma renal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fumador o EPOC con Hto alto	EPO alta, JAK2 negativo: tratar la causa	Flebotomías de entrada
PV de bajo riesgo	Sangrías (Hto < 45%) + aspirina	Quimioterapia o anticoagulación oral
PV mayor de 60 o con trombosis previa	Agregar hidroxiurea	Solo sangrías

REGLA DE ORO **Prurito tras ducha caliente + bazo** — Facies pletórica y panmielosis

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **70–72** (pág. 15) · solucionario págs. 39–40.

Clase 8.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.08.2.006 Neutropenia febril — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Neutropenia febril

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Neutropenia**: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° **≥ 38.3** °C única o **≥ 38.0** °C x **1 hora**.
- La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de **60 minutos** desde la llegada al hospital.
- El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.
- El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.
- La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.
- El paciente con score MASCC **≥ 21** (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.

ALGORITMO · NEUTROPENIA FEBRIL: DE LA FIEBRE AL ANTIBIÓTICO

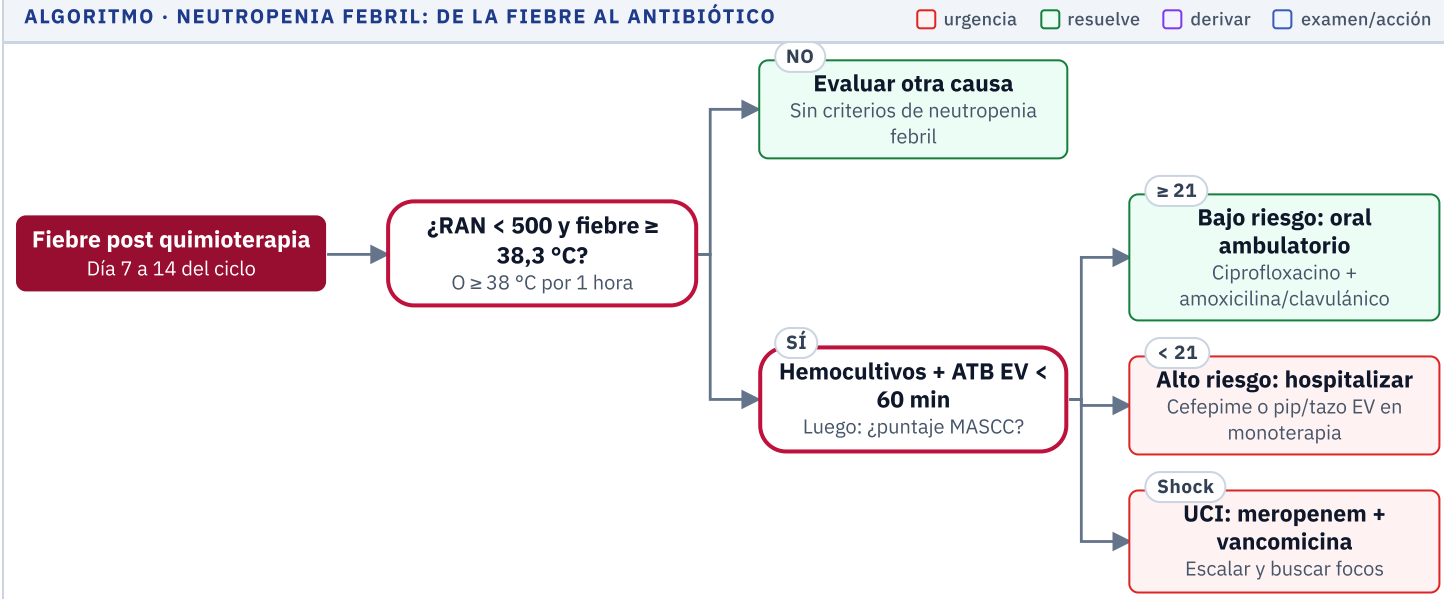


TABLA 8.21 · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL SEGÚN SCORE MASCC

CATEGORÍA DE RIESGO	PUNTAJE MASCC	LUGAR DE ATENCIÓN	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INICIAL DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	≥ 21 Puntos (sin factores de alarma)	Manejo ambulatorio con recontrol estrecho en 24 h	Ciprofloxacino 500-750 mg c/12h VO + Amoxicilina/Clavulánico 875 mg c/8h VO
Alto Riesgo	< 21 Puntos (o neutropenia prolongada)	Hospitalización obligatoria en aislamiento protector / UPC	Monoterapia EV: Cefepime 2 g c/8h EV O Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV
Alto Riesgo + Shock	< 21 Puntos con inestabilidad hemodinámica	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	Meropenem 1 g c/8h EV + Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV + Amikacina
Infección Catéter CVC	Cualquier score con eritema en túnel	Hospitalización en sala / aislamiento	Cefepime o Pip/Tazo + Vancomicina EV; evaluar retiro del catéter si túnel infectado

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fiebre 10 días post quimioterapia	Hemograma con RAN, urgente	Antipiréticos y control
Neutropenia febril sin foco aparente	Antibiótico EV en < 60 min	Esperar radiografía o cultivos
Examen físico del neutropénico	Inspeccionar zona perianal	Tacto rectal o termómetro rectal

REGLA DE ORO **RAN < 500 + fiebre ≥ 38,3 °C** — O ≥ 38 °C sostenida por 1 hora

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **73–75** (págs. 15–16) · solucionario págs. 40–41.

Clase 8.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

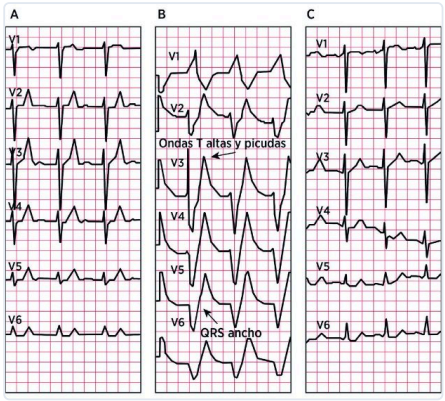
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.08.2.005 Lisis tumoral aguda — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Hipercalcemia · Síndrome de compresión medular · Paraplejia aguda

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios Cairo-Bishop**: hiperuricemia (**≥8**), hiperkalemia (**≥6**), hiperfosfemia (**≥4.5**) e hipocalcemia (**≤7**).
- La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva más Rasburicasa (urato oxidasa).
- La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en pacientes con déficit de G6PD.
- El alopurinol bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico pero no degrada el ya formado; útil en riesgo bajo a intermedio.
- La hipercalcemia maligna se trata con hidratación endovenosa abundante con solución salina seguida de Ácido Zoledrónico EV.



ECG DE HIPERKALEMIA
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 23

ALGORITMO · URGENCIAS ONCOLÓGICAS: EL PRIMER PASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

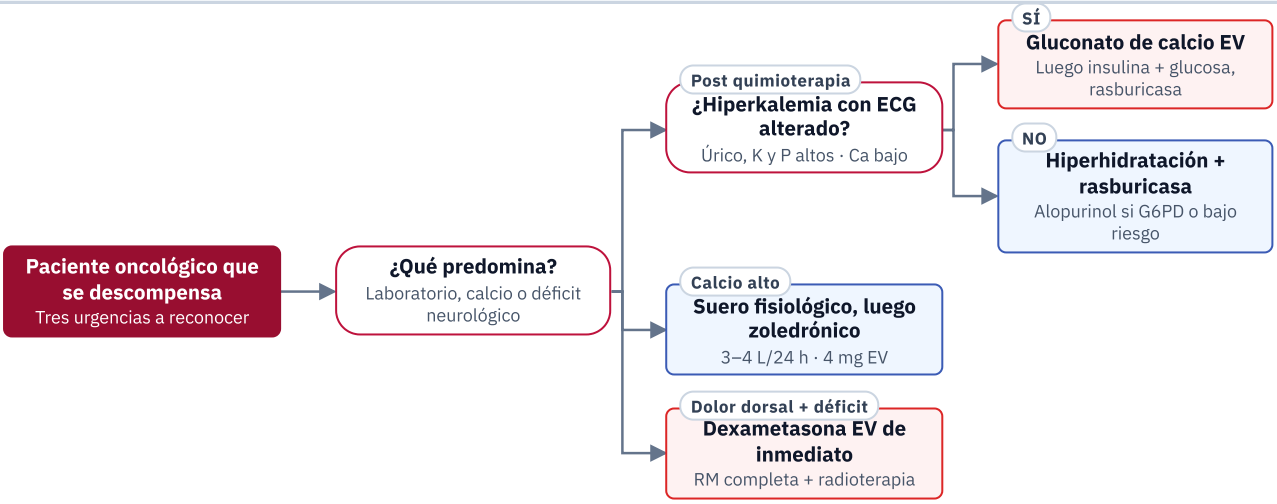


TABLA 8.22 · CRITERIOS DE LABORATORIO DE CAIRO-BISHOP PARA SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

PARÁMETRO METABÓLICO	PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO CAIRO-BISHOP	CAMBIO RESPECTO AL BASAL	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL
Ácido Úrico Plasmático	≥ 8.0 mg/dL (≥ 476 umol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Nefropatía aguda por cristales de urato en túbulos
Potasio Sérico	≥ 6.0 mEq/L (≥ 6.0 mmol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Arritmias ventriculares malignas, FV y paro en diástole
Fósforo Sérico	≥ 4.5 mg/dL (≥ 1.45 mmol/L en adultos)	Aumento del 25% sobre el basal	Precipitación de sales de fosfato cálcico e injuria renal
Calcio Sérico Corregido	≤ 7.0 mg/dL (≤ 1.75 mmol/L)	Disminución del 25% sobre el basal	Tetania, signo de Chvostek/Trousseau, convulsiones y arritmias

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Burkitt o LLA > 100.000 antes de quimioterapia	Hiperhidratación + rasburicasa	Solo alopurinol
Lisis tumoral con déficit de G6PD	Alopurinol + hidratación	Rasburicasa
Lisis con K 6,8 y QRS ancho	Gluconato de calcio EV primero	Esperar la diálisis

REGLA DE ORO **Suben úrico, potasio y fósforo** — Baja el calcio: lo arrastra el fósforo

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **76–83** (págs. 16–17) · solucionario págs. 42–43.

Clase 8.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.019 Trombofilias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome antifosfolípidos · Estudio de trombofilia · Tratamiento anticoagulante

LO QUE TE PREGUNTAN

- La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.
- El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera resistencia a la heparina.
- El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de trombosis ni bajo anticoagulantes.
- **Criterios de Sydney para SAF**: trombosis vascular o morbilidad obstétrica más anticuerpos antifosfolípidos positivos x 2 en >**12 semanas**.
- El Anticoagulante Lúpico produce prolongación paradójica del TTPK in vitro que no corrige con plasma normal.

ALGORITMO · TROMBOFILIAS: A QUIÉN ESTUDIAR Y CÓMO TRATAR

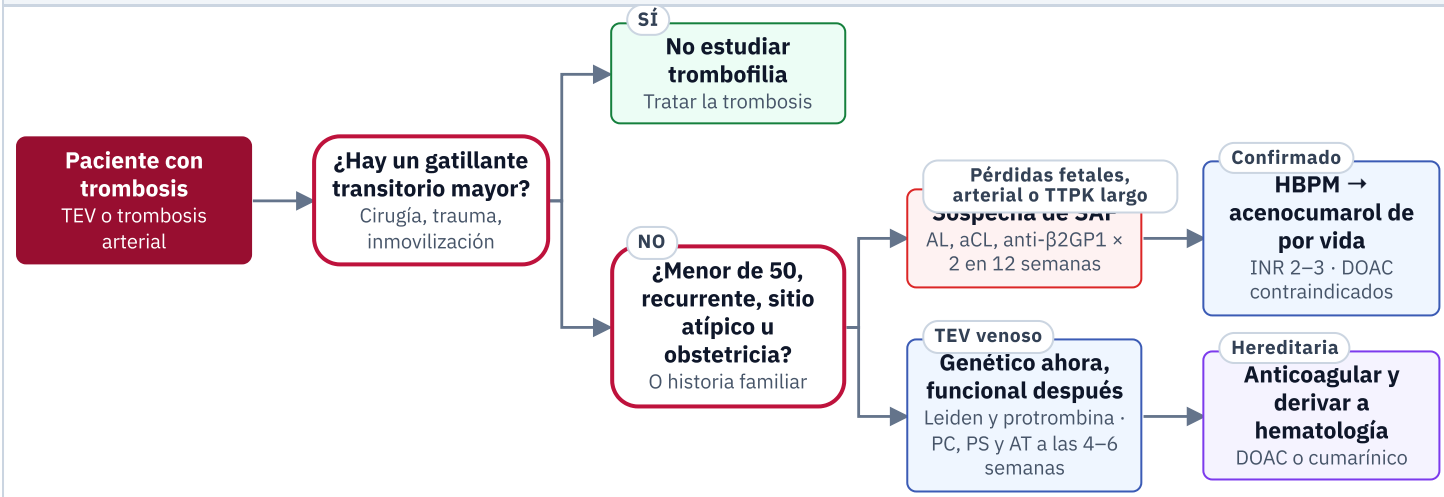


TABLA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS VS SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO: DIAGNÓSTICO Y TERAPIA

CARACTERÍSTICA	FACTOR V LEIDEN (RESISTENCIA A PCA)	DEFICIENCIA DE ANTITROMBINA III	SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF)
Naturaleza de la Trombofilia	Hereditaria (autosómica dominante)	Hereditaria (autosómica dominante)	Adquirida autoinmune (primaria o LES)
Frecuencia Poblacional	La más común en caucásicos (3-5% portadores)	Rara (< 0.02% en población general)	La trombofilia adquirida más frecuente
Tipo de Trombosis	Predominantemente Venosa (TVP / TEP)	Venosa profunda severa recurrente	Venosa (TVP) y Arterial (ACV, infarto, gangrena)
Morbilidad Obstétrica	Riesgo leve a moderado de aborto	Riesgo moderado de pérdida fetal	Abortos recurrentes <10 sem, muerte fetal >10 sem
Prueba Diagnóstica	Resistencia a PCa / PCR mutación G1691A	Actividad funcional de antitrombina en plasma	Anticoagulante lúpico, Anti-cardiolipina, Anti-B2GP1
Anticoagulante de Elección	DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) o Cumarínicos	DOACs o Cumarínicos (Resistencia a heparina)	ACENOCUMAROL / WARFARINA (INR 2-3); ¡DOACs prohibidos!

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

	FACTOR V LEIDEN	DÉFICIT DE ANTITROMBINA	SAF
Origen	Hereditario, AD	Hereditario, AD	Adquirido autoinmune

REGLA DE ORO **Factor V Leiden: la más frecuente** — Resistencia a la proteína C activada

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **84–87** (pág. 17) · solucionario págs. 43–44.

Clase 8.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.3.005 Indicaciones de uso de componentes sanguíneos — Conocimiento general

También: Transfusión y sus complicaciones

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Estrategia restrictiva**: transfundir glóbulos rojos con Hb < **7.0 g/dL** en pacientes hospitalizados estables.
- En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb > **8.0 a 9.0 g/dL**.
- Una unidad de concentrados de glóbulos rojos (CGR) eleva la hemoglobina en **1 g/dL** y el hematocrito en **3%**.
- Umbral de transfusión profiláctica de plaquetas en falla medular: < 10.000/uL; en cirugías mayores: < 50.000/uL.
- **Ante cualquier reacción transfusional aguda**: DETENER LA TRANSFUSIÓN DE INMEDIATO y mantener vía permeable.

ALGORITMO · REACCIÓN TRANSFUSIONAL AGUDA

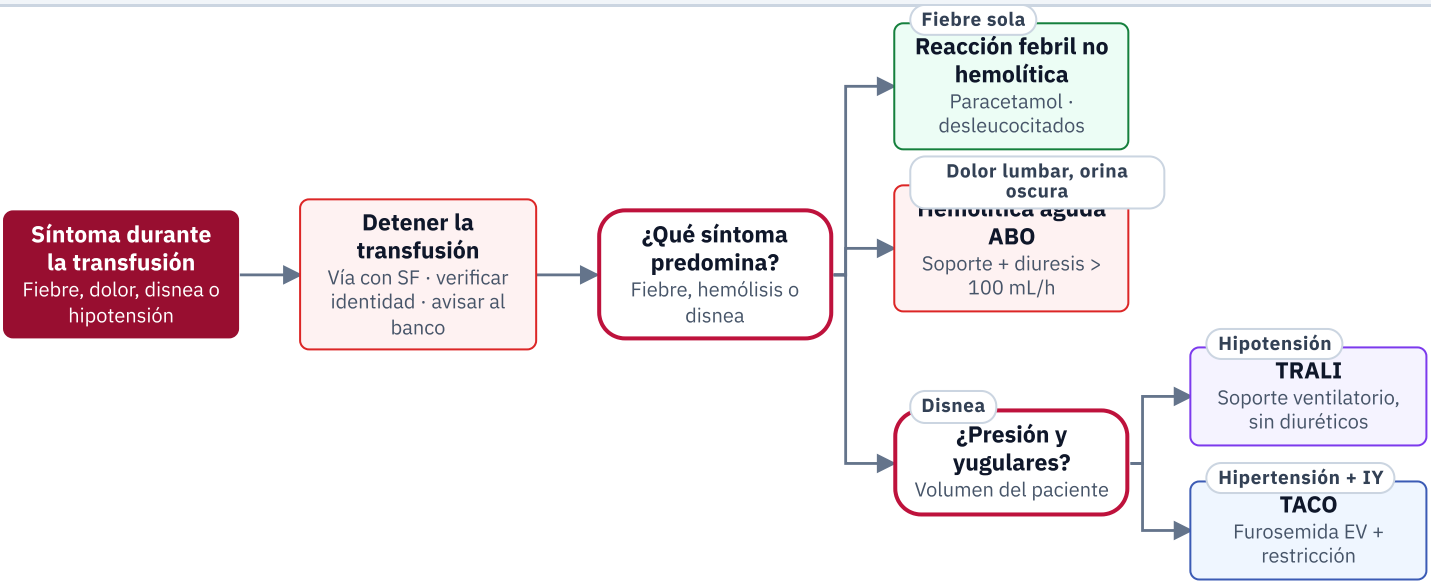


TABLA 8.24 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RESPIRATORIO: TRALI VS TACO EN MEDICINA TRANSFUSIONAL

PARÁMETRO	TRALI (INJURIA PULMONAR AGUDA)	TACO (SOBRECARGA CIRCULATORIA)
Mecanismo Fisiopatológico	Aumento permeabilidad capilar alveolar (Anticuerpos anti-HLA/HNA)	Hipervolemia hidrostática y sobrecarga ventricular izquierda
Presión Arterial Sistémica	Hipotensión o normal	Hipertensión arterial marcada
Presión Venosa / Yugular	Normal o baja (sin ingurgitación yugular)	Ingurgitación yugular franca (> 10 cmH2O) y reflujo
Auscultación Cardíaca	Normal (sin ritmo de galope)	Ritmo de galope con 3er ruido (R3) audible
Péptido Natriurético (BNP)	Normal o levemente elevado	Marcadamente ELEVADO (> 1.5 a 3 veces el basal)
Respuesta a Furosemida EV	Nula o perjudicial (empeora hipotensión)	MEJORÍA CLÍNICA RÁPIDA Y ESPECTACULAR
Tratamiento Primario	Soporte ventilatorio protector (UCI); oxigenoterapia	Furosemida EV (20-40 mg) + Restricción hídrica + Vasodilatadores

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hospitalizado estable, Hb 7,5	No transfundir	Transfundir para llegar a 10
Síndrome coronario agudo, Hb 7,8	Transfundir (umbral 8–9)	Aplicar el umbral de 7

REGLA DE ORO **Glóbulos rojos: Hb < 7** — Coronario: 8–9 · hemorragia masiva: no espera

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **88–90** (pág. 17) · solucionario pág. 45.

Clase 8.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 24 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES	
8.1 Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	pág. 4
Embarazo: Hb < **11 g/dL** — Segundo trimestre: < **10,5 g/dL**	DOSIS
Hombre: Hb < **13 g/dL** — Mujer adulta no embarazada: < **12 g/dL**	DOSIS
8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	pág. 5
Ferritina > 500–1.000 ng/mL — IST > **50–60 %**, ferremia muy alta	DOSIS
Still del adulto o activación macrofágica — Ferritina > 3.000 a 10.000 ng/mL	DOSIS
IST < **15–20 %**: ferropenia — IST > **45–50 %**: sobrecarga de hierro	CORTE
8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	pág. 6
Ferritina < 30 ng/mL — Confirma sin médula	DOSIS
Ferremia e IST bajos (< **15 %**) — Transferrina alta, RDW elevado	CORTE
Con inflamación: ferritina < 100 + IST < **15 %** — También confirma	CORTE
8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	pág. 8
Salvo ferropenia asociada — Ferritina < 100 con PCR alta	CORTE
Primero hierro: ferritina > 200, IST > **20 %** — Después EPO	CORTE
8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	pág. 9
Neutrófilos < 500/µL — Riesgo infeccioso alto	CORTE
Reticulocitos < 20.000/µL o < **1 %** — Médula que no regenera	CORTE
BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS	
8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	pág. 10
B12 < 200 pg/mL — Déficit confirmado	DOSIS
Folato intraeritrocitario < 150 ng/mL — Déficit de folato	DOSIS
Ácido fólico **1 a 5 mg**/día oral — Por **3 a 4 meses**	DOSIS
8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	pág. 11
Hb < 7, disnea de reposo, dolor torácico — LDH > **1.500 UI**/L	DOSIS
Rituximab anti-CD20 — **375 mg**/m² semanal por **4 semanas**	DOSIS
8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	pág. 13
CHCM mayor de **36 g/dL** — El glóbulo está deshidratado	DOSIS
No durante la crisis — Esperar **2 a 3 meses**	TIEMPO
8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	pág. 14
Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.	CORTE
HbA2 mayor de **3,5 %** — Habitualmente **4 a 7 %**	CORTE
8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	pág. 15
Adulto + cerebro fluctuante — PTT: ADAMTS13 < **10 %**	CORTE
Si se retrasa: plasma fresco — **15 a 30 mL/kg**/día	DOSIS
Anemia hemolítica microangiopática — LDH > 1.000, esquistocitos > **1–2 %**	CORTE
BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS	
8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	pág. 16
Monitorizar heparina no fraccionada — Meta: **1,5 a 2,5 veces** el control	META
Factores VII, X, V, II y fibrinógeno — Normal: 11–13,5 s o **70–100 %**	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	pág. 17
Plaquetas muy bajas — A menudo < 20.000/µL	CORTE
Remite sola en > **80 %** — En **3 a 6 meses**, sin secuelas	CORTE
Asintomático o petequias aisladas — Con plaquetas > 30.000/µL	CORTE
8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	pág. 19
Ausencia total, autosómica recesiva — Factor VIII < **1–2 %**	CORTE
SNC o politrauma: meta **100 %** — **50 UI**/kg, antes del TAC	DOSIS
1 UI/kg sube el IX un **1 %** — Hemartrosis 40–50 · vital **100 UI**/kg	DOSIS
8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	pág. 21
Sin sangrado, INR > 10 — Vitamina K oral **2,5–5 mg**	DOSIS
Anti-Xa: andexanet alfa — O CCP **50 UI**/kg si no hay	DOSIS
8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	pág. 22
Crioprecipitado — Fibrinógeno < **100–150 mg/dL**	DOSIS
Plaquetas — Meta > 50.000 si sangra · > 20.000 si no	META
BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES	
8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	pág. 23
Hemograma inicia, mielograma confirma — **≥ 20%** de blastos	CORTE
Protocolo PINDA — Sobrevida libre de enfermedad > **85–90%**	CORTE
Aplasia de **3 a 4 semanas** — Soporte intensivo	TIEMPO
8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	pág. 24
Linfocitos B **≥ 5.000/µL** — Persistentes al menos **3 meses**	CORTE
LLC temprana: observar — Tratar solo si Hb < 10 o plaquetas < 100.000	CORTE
La leucemia del adulto mayor — Sobre **70 años**; rara bajo 40	CORTE
8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	pág. 25
Síntomas B — Fiebre > 38, sudoración, peso > **10%** en **6 meses**	CORTE
Indolora, gomosa, > **2 cm**, > **4–6 semanas** — Sospechar linfoma	CORTE
ABVD cura más del **85%** — GES 38	CORTE
8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	pág. 26
R: creatinina > **2 mg/dL** — O clearance < **40 mL**/min	DOSIS
C: calcio > **11 mg/dL** — O más de 1 sobre el límite normal	DOSIS
8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	pág. 27
TE: plaquetas > 450.000 — Sangra o trombosa	CORTE
Hb > 16,5 (H) · > 16 (M) — O Hto > **49%** (H) · > **48%** (M)	CORTE
BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	
8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	pág. 28
MASCC **≥ 21**: oral ambulatorio — MASCC < 21: hospitalizar	CORTE
Cefepime **2 g** c/**8 h** EV — En infusión extendida	DOSIS
Hemocultivos + antibiótico EV < **60 min** — Nunca tacto rectal	CORTE
8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	pág. 29
Ácido úrico **≥ 8 mg/dL** — Potasio **≥ 6 mEq/L**	DOSIS
Fósforo **≥ 4,5 mg/dL** (adulto) — **≥ 6,5 en** niños	DOSIS
Calcio corregido **≤ 7 mg/dL** — O cambio de **25%** sobre el basal	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	pág. 30
Anticardiolipina IgG o IgM — Títulos moderados o altos, > 40 GPL o MPL	CORTE
Riesgo de TEV **4 a 8 veces** mayor — En heterocigotos	CORTE
Positivo en 2 ocasiones — Separadas por al menos **12 semanas**	TIEMPO
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	pág. 31
Estable: Hb < **7 g/dL** — En sala o UCI · meta 7 a 8	DOSIS
< 10.000: falla medular estable — Profilaxis	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
8.3 **Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa**			pág. 6
Menos dosis, mejor absorción · Esquema actual	**40 a 100 mg de hierro elemental al día**	1 comprimido de **200 mg** = **40–60 mg** elemental	
Menos dosis, mejor absorción · Esquema actual	**En ayunas, con vitamina C**	Mantiene el hierro ferroso soluble	
¿Cuándo pasar a la vena? · Preparados modernos	**Carboximaltosa férrica o hierro sacarato**	**500 a 1.000 mg** en **15 a 30 minutos**	
8.5 **Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos**			pág. 9
Fármacos mielotóxicos	**Antitiroideos: tiamazol y propiltiouracilo**	Mujer joven con Graves	
8.6 **Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**			pág. 10
Déficit de folato	**Metotrexato, trimetoprima, pirimetamina**	Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina	
8.7 **Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**			pág. 11
Primera línea · AHAI caliente	**Prednisona 1 a 1,5 mg/kg/día**	Responde el **70 a 80 %** en **7 a 14 días**	
Primera línea · AHAI caliente	**Ácido fólico 5 mg/día**	La médula acelerada consume folato	
Opciones	**Rituximab anti-CD20**	**375 mg**/m² semanal por **4 semanas**	
Opciones · Esplenectomía electiva	**Vacunas 2 semanas antes**		
8.8 **Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)**			pág. 13
Esplenectomía	**Vacunar antes**	Neumococo, meningococo y Haemophilus	
Casos graves	**Eculizumab o ravulizumab**	Anticuerpos anti-C5 del complemento	
8.9 **Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)**			pág. 14
Anemia de Cooley · Complicación	**Quelantes de hierro**	Deferoxamina o deferasirox	
Crisis vasooclusiva en urgencias · Urgencia	**Opioides de inmediato**	Morfina EV o fentanilo	
Crisis vasooclusiva en urgencias · Urgencia	**Ceftriaxona si hay infección**	Cubre neumococo	
8.10 **Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU**			pág. 15
Plasmaféresis ya, y nunca plaquetas · PTT	**Corticoides en dosis altas**	Metilprednisolona EV o prednisona **1 mg/kg**/día	
8.11 **Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno**			pág. 16
TTPK · Para qué se usa	**Monitorizar heparina no fraccionada**	Meta: **1,5 a 2,5 veces** el control	
8.13 **Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**			pág. 19
Von Willebrand · Desmopresina	**Efecto antidiurético; limitar líquidos**		
8.14 **Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes**			pág. 21
Acenocumarol y warfarina · Mecanismo	**Epóxido reductasa de la vitamina K**		
Antídotos	**Dabigatrán: idarucizumab**	**5 g** EV · neutraliza en minutos	
Antídotos	**Heparina no fraccionada: protamina**	**1 mg** neutraliza **100 UI**	
8.16 **Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**			pág. 23
LLA · Quimioterapia intensiva	**Vincristina, dexametasona, L-asparaginasa, daunorrubicina**		
LLA · Quimioterapia intensiva	**Metotrexato, citarabina y dexametasona**		
Quimioterapia intratecal · La da el hematólogo por punción lumbar	**Metotrexato, citarabina y corticoide**		

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas (cont.)		pág. 31
Quimioterapia intratecal · Tratamiento si hay infiltración meníngea	**Cefalea, pares craneales, blastos en el LCR**	
8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)		pág. 25
Esquemas garantizados y su toxicidad · Hodgkin	**Doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina**	± radioterapia del campo comprometido
Esquemas garantizados y su toxicidad · Hodgkin	**Bleomicina: pulmón · doxorrubicina: corazón**	Toxicidades a vigilar
Esquemas garantizados y su toxicidad · No Hodgkin agresivo B	**Rituximab + CHOP**	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona
Esquemas garantizados y su toxicidad · No Hodgkin agresivo B	**Vincristina: neuropatía · rituximab: VHB**	Reacción infusional, reactivar hepatitis B
8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)		pág. 26
Inducción	**Bortezomib + lenalidomida + dexametasona**	VRd; alternativa CyBorD
Hueso	**Ácido zoledrónico o denosumab**	Para las lesiones óseas
8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia		pág. 27
Policitemia vera · Todos los pacientes	**Aspirina 100 mg/día**	Asociada a las sangrías
8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica		pág. 28
Monoterapia antipseudomónica · Alto riesgo	**Cefepime 2 g c/8 h EV**	En infusión extendida
Monoterapia antipseudomónica · Alto riesgo	**O piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h EV**	Alternativa de igual nivel
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas		pág. 31
La más frecuente y la más benigna · Tratar y prevenir	**Paracetamol**	Responde a antipiréticos

GES de Hematología & Hemostasia

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Tratamiento Integral en Niños y Gestantes

Tema **8.3** · Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa
`1.08.1.002` · `2.01.1.031`
pág. 6

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 1): Insuficiencia Renal Crónica Terminal

Tema **8.4** · Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)
`1.08.1.001` · `1.09.1.004`
pág. 8

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 32): Hemofilia y otras coagulopatías congénitas

Tema **8.13** · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand
`1.08.1.006` · `1.08.2.003` · `1.08.4.005`
pág. 19

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 37 y N° 8): Leucemias en personas de 15 años y más / Menores de 15 años

Tema **8.16** · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante
`1.08.1.009` · `1.08.4.009` · `2.01.1.032`
pág. 23

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Leucemia en personas de 15 años y más (LMC)**

Tema **8.17** · Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)
`1.08.1.010` · `1.08.1.014`
pág. **24**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 38 y N° 8): Linfomas en personas de 15 años y más / Menores de 15 años**

Tema **8.18** · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)
`1.08.1.011` · `1.08.5.002` · `2.01.1.033`
pág. **25**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 72): Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más**

Tema **8.19** · Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)
`1.08.1.007` · `1.08.4.004`
pág. **26**

GES **Garantía Explícita en Salud: Urgencia Vital en Paciente Oncológico GES**

Tema **8.21** · Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica
`1.08.2.006` · `1.04.1.020`
pág. **28**

Sin garantía GES específica (16 temas): 8.1 · 8.2 · 8.5 · 8.6 · 8.7 · 8.8 · 8.9 · 8.10 · 8.11 · 8.12 · 8.14 · 8.15 · 8.20 · 8.22 · 8.23 · 8.24. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **8.12** Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — 17
- ★★★ **8.10** Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU — 15
- ★★★ **8.16** Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — 23
- ★★★ **8.6** Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — 10

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 19–28, 38, 41–43, 55–59.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **8.13** Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand — 19
- ★★★ **8.3** Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — 6
- ★★★ **8.18** Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — 25
- ★★★ **8.22** Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular — 29

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 13–14, 44–49, 63–65, 76–83.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **8.17** Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) — 24
- ★★☆ **8.23** Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo — 30
- ★★☆ **8.2** Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina — 5
- ★★☆ **8.21** Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — 28

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 8–12, 60–62, 73–75, 84–87.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **8.7** Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — 11
- ★★☆ **8.8** Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) — 13
- ★★☆ **8.14** Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes — 21
- ★★☆ **8.19** Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) — 26

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 29–34, 50–52, 66–69.

DÍA 5

4 temas · ★

- ★☆☆ **8.5** Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos — 9
- ★☆☆ **8.9** Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) — 14
- ★☆☆ **8.11** Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno — 16
- ★☆☆ **8.1** Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario — 4

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 1–7, 17–18, 35–36, 39–40.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **8.4** Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) — 8
- ★☆☆ **8.15** Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo — 22
- ★☆☆ **8.20** Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia — 27
- ★☆☆ **8.24** Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas — 31

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 15–16, 53–54, 70–72, 88–90.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 32
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 8.3 · 8.6 · 8.10 · 8.12 · 8.13 · 8.16 · 8.18 · 8.22
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Hémato-oncología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

13 8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES 17

12 8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU 15

12 8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante GES 23

11 8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato 10

10 8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand GES 19

9 8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa GES 6

7 8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) GES 25

7 8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular 29

★★ Prioridad media · 8 temas

5 8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) GES 24

5 8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo 30

4 8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina 5

4 8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica GES 28

3 8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo 11

3 8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 13

3 8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes 21

3 8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) GES 26

★ Prioridad baja · 8 temas

2 8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos 9

2 8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) 14

2 8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno 16

1 8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario 4

1 8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) GES 8

1 8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo 22

1 8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia 27

1 8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas 31